ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

GINECOLOGÍA

90 preguntas de práctica

Oncología Ginecológica

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Ginecología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA					
3.01.1.012	Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q3	Tomo 19 · 19.20 (Pág. 74)
3.01.1.014	Dolor pelviano y dismenorrea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.018	Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q11	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.021	Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q12	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.023	Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q17	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.027	Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.018	Pelviperitonitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.02.1.001	Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q4, Q5, Q6, Q7	Tomo 20 · 20.1 (Pág. 5)
3.02.1.002	Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q9, Q10	Tomo 20 · 20.2 (Pág. 9)
3.02.1.003	Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q13, Q14, Q15, Q16	Tomo 20 · 20.3 (Pág. 11)
3.02.1.004	Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q18	Tomo 20 · 20.4 (Pág. 15)
BLOQUE 2: ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN					
3.01.1.015	Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q21, Q22, Q23, Q24	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.017	Enfermedades de transmisión sexual	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
3.01.1.020	Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q34	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.026	Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q30	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.032	Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q31	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.016	Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q25	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.020	Mastitis abscedada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q20	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.02.1.005	Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q26, Q27, Q28, Q29	Tomo 20 · 20.5 (Pág. 20)
3.02.1.006	Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q32, Q33	Tomo 20 · 20.6 (Pág. 24)
3.02.1.007	Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q35, Q36	Tomo 20 · 20.7 (Pág. 26)
BLOQUE 3: ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN					
3.01.1.019	Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q45, Q46, Q47, Q48, Q49	Tomo 19 · 19.9 (Pág. 30)
3.01.1.022	Oligoanovulación crónica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q37	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.002	Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q38	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.008	Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.02.1.008	Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q41, Q42, Q43, Q44	Tomo 20 · 20.8 (Pág. 28)
3.02.1.009	Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q51, Q52, Q53, Q54	Tomo 20 · 20.9 (Pág. 35)
3.02.1.010	Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q39, Q40	Tomo 20 · 20.10 (Pág. 39)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 4: INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO					
3.01.1.013	Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q62, Q63, Q64	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.016	Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q65, Q66, Q67	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.025	Proceso inflamatorio pelviano	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.030	Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q68	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.02.1.011	Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q56, Q57, Q58, Q59	Tomo 20 · 20.11 (Pág. 41)
3.02.1.012	Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q60, Q61	Tomo 20 · 20.12 (Pág. 45)
3.02.1.013	Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q69, Q70, Q71, Q72	Tomo 20 · 20.13 (Pág. 50)
BLOQUE 5: ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA					
3.01.1.024	Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q79, Q80, Q81, Q82, Q83	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.028	Tumores ováricos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.029	Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q74	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.019	Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.02.1.014	Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q75, Q76, Q77, Q78	Tomo 20 · 20.14 (Pág. 54)
3.02.1.015	Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q84, Q85, Q86, Q87	Tomo 20 · 20.15 (Pág. 58)
3.02.1.016	Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q89, Q90	Tomo 20 · 20.16 (Pág. 62)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Ginecología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
3.01.1.012	Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q3	Tomo 19 · 19.20 (Pág. 74)
3.01.1.013	Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q62, Q63, Q64	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.014	Dolor pelviano y dismenorrea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.015	Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q21, Q22, Q23, Q24	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.016	Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q65, Q66, Q67	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.017	Enfermedades de transmisión sexual	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.018	Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q11	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.019	Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q45, Q46, Q47, Q48, Q49	Tomo 19 · 19.9 (Pág. 30)
3.01.1.020	Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q34	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.021	Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q12	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.022	Oligoanovulación crónica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q37	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.023	Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q17	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.024	Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q79, Q80, Q81, Q82, Q83	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.025	Proceso inflamatorio pelviano	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.026	Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg:	GES	Q30	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia	**Derivar**			
3.01.1.027	Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.028	Tumores ováricos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.029	Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q74	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.030	Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q68	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.032	Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q31	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.002	Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q38	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.008	Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.016	Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q25	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.018	Pelviperitonitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.019	Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.020	Mastitis abscedada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q20	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.02.1.001	Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q4, Q5, Q6, Q7	Tomo 20 · 20.1 (Pág. 5)
3.02.1.002	Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q9, Q10	Tomo 20 · 20.2 (Pág. 9)
3.02.1.003	Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q13, Q14, Q15, Q16	Tomo 20 · 20.3 (Pág. 11)
3.02.1.004	Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q18	Tomo 20 · 20.4 (Pág. 15)
3.02.1.005	Endometriosis y Adenomiosis: Tríada	Dx: **Específico** Tx: **Completo** ·	GES	Q26, Q27, Q28, Q29	Tomo 20 · 20.5 (Pág. 20)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado	Seg: **Completo**			
3.02.1.006	Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q32, Q33	Tomo 20 · 20.6 (Pág. 24)
3.02.1.007	Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q35, Q36	Tomo 20 · 20.7 (Pág. 26)
3.02.1.008	Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q41, Q42, Q43, Q44	Tomo 20 · 20.8 (Pág. 28)
3.02.1.009	Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q51, Q52, Q53, Q54	Tomo 20 · 20.9 (Pág. 35)
3.02.1.010	Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q39, Q40	Tomo 20 · 20.10 (Pág. 39)
3.02.1.011	Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q56, Q57, Q58, Q59	Tomo 20 · 20.11 (Pág. 41)
3.02.1.012	Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q60, Q61	Tomo 20 · 20.12 (Pág. 45)
3.02.1.013	Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q69, Q70, Q71, Q72	Tomo 20 · 20.13 (Pág. 50)
3.02.1.014	Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q75, Q76, Q77, Q78	Tomo 20 · 20.14 (Pág. 54)
3.02.1.015	Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q84, Q85, Q86, Q87	Tomo 20 · 20.15 (Pág. 58)
3.02.1.016	Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q89, Q90	Tomo 20 · 20.16 (Pág. 62)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA

PREGUNTA 1 3.01.1.014

1. [ATENCIÓN PRIMARIA: Dolor pelviano y dismenorrea · 3.01.1.014] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Dolor pelviano y dismenorrea. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 2 3.01.2.018

2. Una paciente de 25 años consulta en el servicio de urgencias por dolor abdominal de 3 días de evolución, que ha aumentado de intensidad. Es sexualmente ac8va y u8liza disposi8vo intrauterino 8po T de cobre como método an8concep8vo. Refiere que el dolor es más intenso en el abdomen bajo, mayor al lado derecho. En su examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 108 por minuto y presión arterial 110/70 mmHg, examen abdominal con dolor a la palpación abdominal baja y signo de Blumberg esbozado a derecha. La especuloscopía muestra cuello uterino con secreción purulenta y el tacto vaginal demuestra dolor a la presión cervical y a la palpación de ambos anexos, mayor a derecha. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Embarazo ectópico
B) Aborto sép2co
C) Torsión ovárica
D) Pelviperitoni2s
E) Apendici2s aguda

PREGUNTA 3 3.01.1.012

3. Una paciente de 38 años, multípara de 4, con antecedente de 5 abortos, que requirieron de legrado, nota disminución progresiva del flujo menstrual, hasta haber caído en amenorrea, desde hace 100 días. Su examen físico no muestra alteraciones y no utiliza métodos anticonceptivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Asherman
B) Menopausia precoz
C) Hiperprolactinemia
D) Síndrome de ovario poliquístico
E) Hipopituitarismo

PREGUNTA 4 3.02.1.001

4. Una paciente de 25 años, con antecedentes de menstruaciones regulares, consulta por amenorrea de 5 meses. No utiliza métodos anticonceptivos hormonales. La prueba de β-hCG en orina resulta negativa. El médico administra Medroxiprogesterona 10 mg al día por vía oral durante 10 días, presentando la paciente un sangrado genital abundante de características menstruales 3 días después de suspender el fármaco (Test de Progesterona positivo). ¿Cuál es la interpretación fisiopatológica de este resultado?

A) Falla ovárica prematura con agotamiento folicular irreversible
B) Presencia de un endometrio adecuadamente proliferado por estrógenos endógenos pero con anovulación
C) Estenosis cervical obstructiva secundaria con retención hemática intrauterina
D) Síndrome de Asherman con sinequias uterinas completas
E) Hipogonadismo hipogonadotropo por tumor selar destructor

PREGUNTA 5 3.02.1.001

5. Una joven de 17 años es evaluada por amenorrea primaria. Al examen físico presenta una talla de 1.70 m, excelente desarrollo mamario Tanner V, pero llama la atención la ausencia casi completa de vello axilar y pubiano (Tanner I). Al examen ginecológico se constata una vagina ciega de 3 cm de profundidad, sin palparse cuello uterino ni útero en la ecografía pelviana. En ambos conductos inguinales se palpan masas móviles no dolorosas. El estudio citogenético informa un cariotipo 46,XY. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
B) Síndrome de Turner
C) Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (Síndrome de Morris)
D) Disgenesia gonadal pura (Síndrome de Swyer)
E) Hiperplasia suprarrenal congénita clásica

PREGUNTA 6 3.02.1.001

6. Una paciente de 33 años, con antecedente de legrado uterino instrumental por aborto incompleto hace 6 meses, consulta por ausencia de menstruación desde el procedimiento. La β-hCG es negativa, TSH y prolactina normales. Se realiza un test de progesterona que resulta negativo. Posteriormente se administra una prueba combinada de estrógenos más progesterona por 21 días, no presentándose sangrado de deprivación. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico sospechado?

A) Resonancia magnética de hipófisis
B) Histeroscopía diagnóstica
C) Cariotipo en sangre periférica
D) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis
E) Medición seriada de hormona antimülleriana

PREGUNTA 7 3.02.1.001

7. Una mujer de 19 años es evaluada por amenorrea primaria y ausencia total de desarrollo puberal (Tanner mamario I). Durante la anamnesis refiere que desde niña no es capaz de percibir los olores (anosmia). Al laboratorio se encuentra FSH de 0.8 mUI/mL y LH de 0.5 mUI/mL (ambas muy disminuidas). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Turner
B) Síndrome de Kallmann
C) Craneofaringioma
D) Insuficiencia ovárica prematura
E) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

PREGUNTA 8 3.01.1.027

8. Una mujer de 52 años presenta reglas irregulares, desde hace 8 meses, asociadas a bochornos frecuentes, con calor, enrojecimiento de la cara, sudoración nocturna y dificultades para dormir. ¿Cuál es la indicación más adecuada para el manejo de los síntomas de esta paciente?

A) Fitoestrógenos
B) Terapia de reemplazo hormonal combinada continua
C) Terapia de reemplazo hormonal combinada cíclica
D) Estrógenos solos continuos
E) Progestágenos solos continuos

PREGUNTA 9 3.02.1.002

9. Una mujer de 22 años consulta por ciclos menstruales que se presentan cada 50 a 70 días, asociados a aumento de vello facial en mentón y patillas. En la ecografía ginecológica transvaginal se aprecian ambos ovarios con 24 microfolículos periféricos de 3 a 7 mm y un volumen ovárico de 13 mL cada uno. La paciente no desea embarazo en este momento. Además de recomendar cambios en el estilo de vida y baja de peso, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?

A) Inducción de ovulación con Citrato de Clomifeno
B) Anticonceptivos orales combinados con progestágeno antiandrogénico (ej. Etinilestradiol con Dienogest o Ciproterona)
C) Dexametasona oral a altas dosis de por vida
D) Resección ovárica en cuña por laparoscopía
E) Danazol oral continuo

PREGUNTA 10 3.02.1.002

10. ¿Cuál es la complicación neoplásica ginecológica a largo plazo cuya incidencia se encuentra significativamente aumentada en mujeres jóvenes con Síndrome de Ovario Poliquístico y anovulación crónica que no reciben tratamiento hormonal progestativo periódico?

A) Cáncer de cuello uterino por virus del papiloma humano
B) Carcinoma de endometrio tipo I (endometrioide)
C) Cáncer epitelial seroso de ovario de alto grado
D) Coriocarcinoma gestacional persistente
E) Sarcoma del estroma endometrial

PREGUNTA 11 3.01.1.018

11. Una paciente de 48 años consulta por sangrado uterino, que no ha cesado desde su última menstruación, que inició hace dos semanas. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra útero de tamaño normal, con endometrio de 19 mm de grosor y sin alteraciones anexiales. Su PAP, realizado hace poco es normal y su test de embarazo en orina es negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Histerectomía
B) Ácido tranexámico endovenoso
C) Estrógenos inyectables
D) Anticonceptivos orales combinados
E) Biopsia de endometrio

PREGUNTA 12 3.01.1.021

12. Una paciente de 30 años, nulípara, consulta por presentar reglas abundantes, asociado a astenia e hipersomnia. Al examen físico destacan mucosas pálidas, sin otros hallazgos. Se realiza hemograma donde destaca hemoglobina que resulta en 8mg/dL, y además se realiza ecografía transvaginal que muestra presencia de dos miomas intramurales. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Anticonceptivos orales
B) Agonistas de las gonadotrofinas
C) Histerectomía
D) Miomectomía
E) Observación

PREGUNTA 13 3.02.1.003

13. Una paciente de 47 años consulta por sangrado uterino anormal de 4 meses de evolución, con menstruaciones abundantes y sangrados intermenstruales ocasionales. Al examen físico no se palpan masas pelvianas y la especuloscopía muestra cuello uterino macroscópicamente sano. La ecografía transvaginal informa útero de dimensiones normales y endometrio de 12 mm de grosor sin miomas ni pólipos identificables. ¿Cuál es la conducta médica de primera línea más adecuada antes de iniciar cualquier terapia hormonal?

A) Instalación inmediata de un DIU liberador de levonorgestrel sin estudios adicionales
B) Realización de una biopsia de endometrio ambulatoria con cánula de Pipelle
C) Histerectomía total abdominal profiláctica
D) Prescripción de ácido tranexámico oral y alta sin seguimiento
E) Observación durante 6 meses con calendario menstrual

PREGUNTA 14 3.02.1.003

14. **Una adolescente de 14 años es traída a la urgencia por metrorragia abundante de 10 días de evolución desde su menarquia hace 4 meses, asociando astenia y palidez. No tiene antecedentes de actividad sexual. El hemograma muestra hemoglobina de 8.0 g/dL. En la anamnesis remota la madre refiere que la niña siempre ha presentado epistaxis frecuentes y equimosis fáciles ante traumatismos mínimos. ¿Cuál es la sospecha etiológica de causa no estructural (clasificación FIGO) más probable?**

A) Adenomiosis uterina difusa
B) Coagulopatía congénita (Enfermedad de von Willebrand)
C) Adenocarcinoma de células claras de endometrio
D) Pólipo endometrial gigante
E) Leiomioma submucoso pediculado

PREGUNTA 15 3.02.1.003

15. **¿Cuál de los siguientes métodos terapéuticos médicos ha demostrado la mayor tasa de reducción del volumen de sangrado menstrual (superior al 90% a los 6 meses) y constituye el tratamiento médico de elección para el sangrado uterino anormal de causa endometrial o disovulatoria?**

A) Ácido acetilsalicílico oral en dosis bajas
B) Dispositivo intrauterino liberador de Levonorgestrel (DIU-LNG)
C) Dispositivo intrauterino de Cobre (T de Cobre)
D) Anticonceptivos orales de solo progestágeno en dosis intermitentes
E) Vitamina K intramuscular semanal

PREGUNTA 16 3.02.1.003

16. **Una paciente de 56 años, menopáusica desde hace 5 años sin terapia de reemplazo hormonal, consulta por un episodio de sangrado vaginal rojo oscuro de 3 días de evolución. La especuloscopía descarta lesiones en cérvix y vagina. La ecografía transvaginal revela un endometrio engrosado de 9 mm, heterogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial prioritario que debe descartarse y la conducta obligatoria?**

A) Descartar Cáncer de Endometrio mediante Biopsia Endometrial (Pipelle o histeroscópica)
B) Tratar como vaginitis atrófica con óvulos de estriol sin necesidad de biopsia
C) Indicar progestágenos orales por 10 días y reevaluar ecográficamente en 1 año
D) Indicar reposo en cama y control en APS si no repite el sangrado
E) Realizar laparoscopía exploradora de urgencia para ooforectomía bilateral

PREGUNTA 17 3.01.1.023

17. **Una paciente de 68 años, nulípara, con antecedente de menopausia a los 50 años, consulta debido a sangrado genital intermitente de 2 meses de evolución, con cuantía variable. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra un endometrio de 13 mm de grosor de aspecto heterogénea, con áreas microquísticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hiperplasia endometrial
B) Miomatosis endometrial
C) Atrofia endometrial
D) Pólipo endometrial
E) Cáncer de endometrio

PREGUNTA 18 3.02.1.004

18. **Una paciente de 34 años, nuligesta, que desea embarazarse en el corto plazo, consulta por hipermenorrea de 7 meses de evolución. En la ecografía transvaginal e histerosonografía se identifica un leiomioma submucoso único de 3.5 cm de diámetro localizado en la pared anterior con protrusión del 80% hacia la cavidad endometrial (FIGO 1). El resto del miometrio es normal. ¿Cuál es el tratamiento de elección para esta paciente?**

A) Histerectomía total por vía laparoscópica
B) Resección del mioma mediante Miomectomía Histeroscópica
C) Embolización de arterias uterinas bilateral
D) Administración continua de análogos de GnRH durante 5 años
E) Radioterapia pélvica fraccionada

BLOQUE 2 ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN

PREGUNTA 19 3.01.1.017

19. Una paciente de 31 años multípara de uno, cursando un embarazo de 34 semanas, sin patología previa, acude a control, objetivándose lesiones vaginales, que se muestran a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cesárea electiva
B) Aplicación local de podofilino
C) Iniciar aciclovir oral
D) Realizar tocaciones con ácido tricloroacético
E) Inducir el parto en este momento

PREGUNTA 20 3.01.2.020

20. Una paciente de 32 años, puérpera de parto vaginal eutócico de 8 días de evolución, consulta por dolor mamario derecho, mayor durante la lactancia. Al examen físico tiene T°: 38,5°C, FC: 100x', PA: 120/78 mmHg. Ambas mamas se observan eritematosas, con grietas visibles en el pezón y, en el lado derecho, se palpa aumento de volumen doloroso y fluctuante a la palpación, de 6 cm de diámetro, con aumento de la temperatura local y eritema. El examen ginecológico no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antibióticos endovenosos más drenaje quirúrgico o por punción guiado por ecografía
B) Drenaje por punción
C) Suspender la lactancia materna
D) Frío local y paracetamol
E) Amoxicilina más ácido clavulánico vía oral

PREGUNTA 21 3.01.1.015

21. Mujer de 38 años con dismenorrea severa, dispareunia profunda y menometrorragia. Ecografía transvaginal: útero aumentado de tamaño con ecotextura heterogénea, sin miomas definidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Endometriosis
B) Pólipo endometrial
C) Hiperplasia endometrial
D) Mioma uterino intramural
E) Adenomiosis

PREGUNTA 22 3.01.1.015

22. Paciente femenina 50 años aprox o 38 años (alguien recuerda?), tiene antecedente de esterilización y adenomiosis ¿Cual es el manejo? a. Histerectomía con preservación de ovarios

A) Amoxicilina
B) Ibuprofeno
C) Paracetamol
D) Omeprazol
E) Metformina

PREGUNTA 23 3.01.1.015

23. Una mujer de 32 años consulta por dismenorrea de 2 años de evolución, progresiva. Al examen ginecológico se palpa un tumor anexial derecho. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra un tumor ovárico derecho, de 6,5 cm de diámetro y aspecto quístico, en vidrio esmerilado. Su Ca-125 resulta 86 UI/L (VN: < 35 UI/L). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Carcinoma epitelial
B) Endometrioma ovárico
C) Teratoma maduro
D) Disgerminoma ovárico
E) Quiste folicular

PREGUNTA 24 3.01.1.015

24. Mujer de 18 años consulta por dismenorrea secundaria, intensa, de 6 meses de evolución que ha aumentado progresivamente, por lo que ha tomado AINEs y paracetamol sin respuesta. Su examen Fsico y ginecológico son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar an2concep2vos orales
B) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de pelvis
C) Realizar laparoscopía diagnós2ca
D) Solicitar TAC de pelvis
E) Realizar histeroscopía

PREGUNTA 25 3.01.2.016

25. Una paciente de 19 años, con ciclos menstruales regulares, consulta por dolor ab- dominal intenso, mayor en la fosa ilíaca izquierda. Su FUR fue hace 20 días. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la FII, con signos peritoneales esbozados. Se solicita test de embarazo, que resulta negativo y una ecografía transvaginal, que muestra una lesión anexial mixta de 8 cm de diámetro, con presencia de líquido libre en mode- rada cantidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cuerpo lúteo hemorrágico
B) Cuerpo lúteo roto
C) Apendicitis aguda
D) Torsión ovárica
E) Absceso tubo-ovárico

PREGUNTA 26 3.02.1.005

26. Una paciente de 26 años consulta por dismenorrea secundaria severa que le impide asistir al trabajo durante sus menstruaciones, dispareunia profunda y dispareunia al defecar (disquecia) durante los días de sangrado. Al tacto bimanual se palpa el útero en retroversoflexión fija con gran sensibilidad en los ligamentos uterosacros. La ecografía ginecológica muestra un quiste ovárico derecho de 3.5 cm con ecos internos homogéneos de bajo nivel en 'vidrio esmerilado'. La paciente no desea embarazo en la actualidad. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico oral de primera línea de elección para el control de sus síntomas dolorosos?

A) Paracetamol 500 mg cada 12 horas solo durante el sangrado
B) Dienogest 2 mg al día por vía oral de forma continua
C) Metotrexato intramuscular a dosis única
D) Citrato de Clomifeno oral por 5 días cada mes
E) Terapia de reemplazo hormonal con estrógenos equinos solos

PREGUNTA 27 3.02.1.005

27. Una mujer de 30 años, con antecedente de dolor pélvico crónico e infertilidad primaria de 2 años, se somete a una ecografía transvaginal que revela un quiste ovárico de 5 cm de diámetro de pared delgada, regular, con ecogenicidad interna difusa y homogénea de bajo nivel ('aspecto en vidrio esmerilado'), sin flujo Doppler al interior y sin excrecencias papilares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta lesión ovárica?

A) Cistoadenocarcinoma seroso de ovario
B) Endometrioma ovárico
C) Teratoma quístico maduro (quiste dermoide)
D) Quiste folicular simple funcional
E) Absceso tubo-ovárico roto

PREGUNTA 28 3.02.1.005

28. ¿Por qué razón farmacológica el tratamiento médico hormonal con anticonceptivos orales combinados o progestágenos continuos NO está indicado como tratamiento de la infertilidad en una paciente con endometriosis que busca activamente un embarazo?

A) Porque son teratogénicos irreversibles para cualquier ovocito futuro
B) Porque suprimen la ovulación y no mejoran las tasas de fertilidad ni de nacidos vivos tras suspenderlos, retrasando el tratamiento reproductivo efectivo
C) Porque causan oclusión tubárica bilateral irreversible por fibrosis miometrial
D) Porque aumentan la incidencia de embarazo molar recurrente
E) Porque aceleran la apoptosis de la reserva folicular ovárica

PREGUNTA 29 3.02.1.005

29. Una paciente de 42 años, multípara de 3, consulta por hipermenorrea severa y dismenorrea secundaria progresiva. Al examen físico se palpa un útero aumentado de tamaño difusamente de 11 semanas, simétrico, reblandecido y difusamente doloroso al tacto bimanual. La ecografía transvaginal muestra engrosamiento asimétrico del miometrio posterior con estriaciones lineales y microquistes miometriales. La biopsia endometrial es benigna. Tras fallar el tratamiento médico, se decide una histerectomía total. ¿Qué hallazgo anatomopatológico confirmará el diagnóstico definitivo?

A) Glándulas y estroma endometrial ectópicos en el espesor del miometrio con hipertrofia muscular concéntrica (Adenomiosis)
B) Proliferación clonal de células fusiformes de músculo liso miometrial (Leiomioma)
C) Infiltración estromal por células mesenquimatosas malignas con atipias (Leiomiosarcoma)
D) Pólipo vascular fibroepitelial endocervical
E) Tejido decidual ectópico confinado exclusivamente a la serosa peritoneal

PREGUNTA 30 3.01.1.026

30. Una paciente de 58 años, multípara de cuatro, presenta sensación de peso vaginal, asociada a escapes de orina, al inicio del deseo miccional. Al examen físico presenta prolapso genital. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar oxibutinina oral
B) Realizar prueba Q-TIP
C) Realizar pelvic organ prolapse quantification (POP-Q)
D) Solicitar resonancia magnética pelviana
E) Realizar histerectomía

PREGUNTA 31 3.01.1.032

31. Una paciente de 57 años, multípara de 5, presenta incontinencia de esfuerzos moderados. Su examen físico muestra genitales normales, sin prolapso. Tiene sedimento de orina normal y urocultivo negativo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

A) Oxibutinina
B) Suspensión uretral
C) Terapia de remplazo hormonal
D) Kinesioterapia pélvica
E) Doxasozina

PREGUNTA 32 3.02.1.006

32. Una paciente de 62 años consulta por sensación de peso genital y escapes de orina involuntarios que ocurren exclusivamente cuando estornuda, tose o levanta objetos pesados. No presenta nicturia ni deseos miccionales apremiantes. Al examen físico se evidencia salida de orina sincrónica con la maniobra de Valsalva y un prolapso de la pared vaginal anterior cuyo punto de mayor descenso se sitúa a 2 cm por fuera del anillo himenal (+2 cm, Estadio III). Tras fracasar la kinesioterapia de piso pélvico, se programa cirugía. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico de elección para resolver la incontinencia urinaria de esfuerzo?

A) Colocación de cabestrillo mediouretral libre de tensión (cinta TOT o TVT)
B) Inyección intravesical de toxina botulínica en el músculo detrusor
C) Prescripción oral de oxibutinina a dosis altas
D) Cistoplastía de aumento con parche intestinal
E) Denervación quirúrgica de los plexos hipogástricos inferiores

PREGUNTA 33 3.02.1.006

33. Una mujer de 68 años acude a control refiriendo que con frecuencia experimenta una sensación urgente, súbita e incontenible de orinar, no alcanzando a llegar al baño y perdiendo abundantes volúmenes de orina. Además, orina 12 veces al día y se despierta 3 a 4 veces por noche para miccionar. El examen físico y el sedimento de orina son normales. ¿Cuál de las siguientes conductas terapéuticas es la más apropiada?

A) Indicar colocación de cabestrillo suburetral transobturador (TOT)
B) Iniciar reeducación vesical combinada con un fármaco anticolinérgico como Solifenacina o un agonista beta-3 como Mirabegrón
C) Indicar restricción total de líquidos a menos de 500 mL al día
D) Realizar uretrotomía interna bajo anestesia
E) Indicar tratamiento antibiótico empírico continuo con ciprofloxacino por 6 meses

PREGUNTA 34 3.01.1.020

34. Una pareja joven consulta por infertilidad, refieren que llevan 15 meses intentando tener hijos pero no han tenido resultado, ambos no tienen hijos anteriormente. El hombre trae consigo espermiograma que se realizó hace dos semanas que está normal. Ella nunca ha utilizado anticonceptivos orales y refiere ciclos menstruales normales, su examen físico resulta normal. El examen de elección para continuar el estudio de infertilidad en este caso es:

A) Repetir espermiograma
B) Test post coital
C) Laparoscopía
D) Histeroscopía
E) Histerosalpingografía

PREGUNTA 35 3.02.1.007

35. **Una pareja acude a consulta por no lograr embarazo tras 2 años de búsqueda. En el estudio básico inicial se realiza una Histerosalpingografía a la mujer, informándose obstrucción tubárica bilateral con hidrosálpinx bilateral y prueba de Cotte negativa. El espermiograma del cónyuge y la reserva ovárica de la mujer son normales. ¿Cuál es el tratamiento de fertilidad más adecuado que debe indicarse?**

A) Inseminación intrauterina con semen de donante
B) Inducción de ovulación con Citrato de Clomifeno y relaciones sexuales programadas
C) Fertilización In Vitro (FIV)
D) Inseminación intrauterina con semen del cónyuge capacitado
E) Antibioticoterapia continua con Doxiciclina durante 6 meses

PREGUNTA 36 3.02.1.007

36. **En el estudio de un varón de 30 años cuya pareja no logra concebir, se solicita un espermiograma de control. Para que los resultados del análisis seminal según los estándares internacionales de la OMS sean válidos y confiables, ¿cuántos días de abstinencia sexual previa debe cumplir el paciente antes de recolectar la muestra?**

A) Menos de 24 horas de abstinencia
B) De 3 a 5 días de abstinencia estricta
C) Al menos 20 a 30 días de abstinencia
D) La abstinencia sexual previa es irrelevante para el espermiograma
E) Exactamente 14 días coincidiendo con el ciclo de la pareja

BLOQUE 3 ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN

PREGUNTA 37 3.01.1.022

37. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Oligoanovulación crónica · 3.01.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Oligoanovulación crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 3.01.2.002

38. **Mujer de 20 años tras parto vaginal con episiotomía presenta aumento de volumen doloroso, azulado y fluctuante en el labio mayor derecho de 48 horas de evolución. Sin fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo más adecuado?**

A) Hematoma vulvar: compresas frías y analgesia si no aumenta
B) Absceso vulvar: drenaje + antibióticos
C) Quiste de Bartolino: observación ambulatoria
D) Linfocele: punción aspirativa
E) Tromboflebitis pélvica: anticoagulación

PREGUNTA 39 3.02.1.010

39. **Una paciente de 31 años consulta por dolor vulvar progresivo e invalidante que le impide sentarse. Al examen ginecológico se aprecia una masa de 5 cm de diámetro en el labio mayor izquierdo, en posición de las 4 horas del reloj, caliente, fluctuante, muy eritematosa y de extrema sensibilidad al tacto. Se diagnostica un absceso de la glándula de Bartolino. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico de elección para resolver el cuadro y prevenir la recidiva?**

A) Punción evacuadora con aguja fina bajo anestesia local
B) Incisión, drenaje y marsupialización de la glándula (o colocación de catéter de Word)
C) Vulvectomía simple izquierda
D) Prescripción exclusiva de antibióticos orales sin drenar el absceso
E) Cauterización química con nitrato de plata de la mucosa vestibular

PREGUNTA 40 3.02.1.010

40. **Una mujer de 64 años consulta por prurito vulvar intenso y constante de más de 8 meses de evolución que le interrumpe el sueño. Al examen físico se aprecia atrofia severa de los labios menores con enterramiento parcial del clítoris y placas blanquecinas nacaradas adelgazadas de aspecto en papel apergaminado distribuidas en la vulva y región perianal en 'figura de ocho', sin úlceras activas. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el fármaco tópico de primera línea de elección?**

A) Candidiasis vulvovaginal crónica; Clotrimazol en crema al 1%
B) Liquen Escleroso Vulvar; Propionato de Clobetasol al 0.05% en ungüento tópico
C) Condilomas acuminados gigantes; Imiquimod al 5% en crema
D) Herpes genital recurrente; Aciclovir tópico en crema
E) Psoriasis invertida; Ácido salicílico al 10%

PREGUNTA 41 3.02.1.008

41. Una paciente de 36 años, sin antecedentes cardiovasculares pero fumadora activa de una cajetilla diaria (20 cigarrillos al día), solicita inicio de método anticonceptivo. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADO (Categoría 4 de la OMS) en esta paciente?

A) Dispositivo intrauterino de cobre (T de Cobre)
B) Implante subdérmico liberador de etonogestrel
C) Anticonceptivos orales combinados de etinilestradiol con levonorgestrel
D) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel
E) Minipíldora oral de desogestrel

PREGUNTA 42 3.02.1.008

42. Una joven de 20 años consulta en el servicio de urgencia 18 horas después de una relación sexual no protegida por rotura del condón. Solicita la píldora de anticoncepción de emergencia. ¿Cuál es el fármaco de elección, la dosis recomendada y el mecanismo de acción de la píldora de anticoncepción de emergencia disponible en el sistema público chileno?

A) Mifepristona 200 mg oral; desprendimiento del blastocisto implantado
B) Levonorgestrel 1.5 mg oral en dosis única; retraso o inhibición del pico ovulatorio de LH
C) Misoprostol 800 mcg vaginal; inducción de contracciones uterinas expulsivas
D) Metotrexato 50 mg intramuscular; lisis de las células trofoblásticas
E) Estrógenos conjugados a altas dosis; inducción de hemorragia masiva

PREGUNTA 43 3.02.1.008

43. Una paciente de 28 años con antecedente de migraña clásica con aura visual (escotomas centelleantes) frecuente acude a solicitar anticoncepción hormonal. Al evaluar las alternativas, ¿cuál de los siguientes métodos está formalmente contraindicado por clasificarse como Categoría 4 de la OMS?

A) Anillo vaginal liberador de etinilestradiol y etonogestrel
B) Implante subdérmico de etonogestrel
C) Dispositivo intrauterino de cobre
D) Minipíldora de desogestrel
E) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

PREGUNTA 44 3.02.1.008

44. Una paciente que tomó la píldora de anticoncepción de emergencia de levonorgestrel 1.5 mg presenta un episodio de vómito profuso 45 minutos después de haber deglutido el comprimido. ¿Cuál es la indicación médica correcta a seguir?

A) No realizar ninguna acción, pues la absorción intestinal completa ocurre en los primeros 15 minutos
B) Repetir de inmediato la dosis completa de 1.5 mg de Levonorgestrel, idealmente asociando un antiemético oral
C) Indicar que el método fracasó y que debe programarse una interrupción legal del embarazo
D) Administrar antibióticos profilácticos para evitar infecciones
E) Esperar 1 semana y realizar un test de embarazo en sangre

PREGUNTA 45 3.01.1.019

45. Mujer de 28 años con dispareunia (dolor a la penetración), flujo vaginal gris homogéneo con mal olor (peor post coito) y pH vaginal 5.5. Test de aminas positivo (KOH). ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

A) Vaginosis bacteriana: metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días
B) Candidiasis vaginal: fluconazol oral 150 mg dosis única
C) Tricomoniasis: metronidazol 2 g dosis única
D) Herpes genital: aciclovir
E) Cervicitis por clamidia: azitromicina

PREGUNTA 46 3.01.1.019

46. Una paciente de 31 años de edad refiere mal olor genital, asociado a flujo, que empeora cuando tiene relaciones sexuales. Es usuaria de dispositivo intrauterino de cobre, desde hace 4 años. No tiene PAP vigente, por lo que se solicita un nuevo PAP, que resulta normal. En la especuloscopía se observa leucorrea de color gris, sin lesiones cervicales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Retirar el DIU bajo cobertura antibiótica
B) Solicitar cultivo de secreción vaginal
C) Indicar clindamicina tópica en óvulos
D) Indicar clotrimazol tópico en óvulos
E) Indicar fluconazol oral

PREGUNTA 47 3.01.1.019

47. Una paciente de 27 años, usuaria de dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, consulta por flujo genital de mal olor que empeora después de tener relaciones sexuales. Al examen físico se observa cuello uterino normal y secreción vaginal de color gris. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Retirar el dispositivo intrauterino bajo cobertura antibiótica
B) Indicar fluconazol vía oral
C) Iniciar doxiciclina vía oral
D) Realizar VDRL a la paciente y a su pareja.
E) Indicar metronidazol por vía oral

PREGUNTA 48 3.01.1.019

48. Embarazada de 20 semanas con urocultivo positivo para E. coli sensible. Sin alergias. ¿Cuál es el antibiótico de elección para la infección urinaria en el embarazo?

A) Cefalexina oral por 7 días
B) Amoxicilina oral
C) Cotrimoxazol (contraindicado en tercer trimestre)
D) Ciprofloxacino (contraindicado en embarazo)
E) Nitrofurantoína (evitar en tercer trimestre)

PREGUNTA 49 3.01.1.019

49. Una paciente de 26 años, sin antecedentes, consulta por secreción vaginal asociada a prurito. Al examen físico se aprecia liquenificación y signos de grataje a nivel vulvar, a la especuloscopía se aprecia leucorrea blanquecina. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

A) Metronidazol
B) Fluconazol
C) Miconazol
D) Doxiciclina
E) Ceftriaxona

PREGUNTA 50 3.01.2.008

50. **Mujer de 55 años postmenopáusica con miomas uterinos conocidos. Llega a urgencias por metrorragia severa con hipotensión 90/60 mmHg y FC 118 lpm. ¿Cuál es el manejo inmediato?**

A) Estabilización hemodinámica + histerectomía de urgencia
B) Ácido tranexámico EV y observar
C) Progestágenos EV en dosis alta
D) Embolización uterina electiva
E) Solo transfusión de GR y alta

PREGUNTA 51 3.02.1.009

51. **Una paciente de 25 años acude por flujo vaginal abundante con olor fétido a pescado, que se acentúa después de las relaciones sexuales y de la menstruación. No refiere prurito ni dolor. Al examen con espéculo se observa una secreción homogénea, fluida, de color blanco-grisáceo que recubre la vagina. El pH vaginal es de 5.2. Al agregar una gota de KOH al 10% a la muestra de flujo se desprende un intenso olor a aminas (Whiff test positivo). Al examen microscópico en fresco se aprecian células epiteliales con bordes citoplasmáticos borrosos cubiertos de bacterias ('clue cells'). ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de elección?**

A) Fluconazol 150 mg oral en dosis única a la paciente y a su pareja
B) Metronidazol 500 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días a la paciente
C) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única
D) Nistatina en crema tópica vulvar por 14 días
E) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 días a ambos cónyuges

PREGUNTA 52 3.02.1.009

52. **Una mujer de 29 años en tratamiento con amoxicilina por una sinusitis acude a consulta por prurito vulvar desesperante y sensación de ardor al orinar de 3 días de evolución. Al examen físico se evidencia marcado eritema y edema vulvar con fisuras por rascado, y al colocar el espéculo se aprecia una leucorrea blanca espesa en grumos, similar a 'leche cortada', intensamente adherida a las paredes vaginales. El pH vaginal es de 4.0 y el test de aminas con KOH al 10% resulta negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis
B) Candidiasis vulvovaginal
C) Tricomoniasis vaginal sintomática
D) Cervicitis mucopurulenta por Chlamydia trachomatis
E) Vaginitis atrófica senil

PREGUNTA 53 3.02.1.009

53. **¿En cuál de las siguientes infecciones ginecológicas del tracto genital inferior es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO prescribir tratamiento farmacológico simultáneo a todas las parejas sexuales de la paciente para evitar la reinfección y cortar la cadena de transmisión epidemiológica?**

A) Vaginosis bacteriana recurrente
B) Candidiasis vulvovaginal esporádica
C) Tricomoniasis vaginal
D) Vaginitis inflamatoria descamativa
E) Infección urinaria baja por Escherichia coli

PREGUNTA 54 3.02.1.009

54. **Una paciente de 21 años consulta por leucorrea purulenta y sangrado postcoital ocasional. A la especuloscopía se observa salida de secreción mucopurulenta espesa por el orificio cervical externo y cuello uterino marcadamente friable que sangra con facilidad al pasar la tórula. La paciente se encuentra afebril y sin dolor a la palpación uterina ni anexial. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano empírico recomendado por las guías del MINSAL mientras se esperan los resultados microbiológicos?**

A) Metronidazol 500 mg cada 12 horas por 7 días oral exclusivamente
B) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única MÁS Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días
C) Amoxicilina 500 mg cada 8 horas oral por 10 días
D) Fluconazol 150 mg oral en dosis única
E) Clotrimazol en crema vaginal por 3 noches

BLOQUE 4 INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO

PREGUNTA 55 3.01.1.025

55. **Una paciente de mantiene actividad sexual, sin método anticonceptivo, consulta por fiebre, asociada a dolor abdominal de 3 días de evolución. Al examen físico presenta abdomen sensible y al examen ginecológico destaca útero doloroso, tanto a la palpación, como a la movilización. Se solicitan exámenes, que muestran test de embarazo negativo, hemograma con leucocitos: 18.000 por campo y PCR: 8,0 mg/L. La ecografía transvaginal muestra presencia de líquido libre escaso en la cavidad peritoneal, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar tratamiento sintomático con ácido mefenámico
B) Realizar cultivo endocervical
C) Indicar anticonceptivos orales
D) Iniciar tratamiento antibiótico
E) Realizar laparotomía exploradora

PREGUNTA 56 3.02.1.011

56. **Una joven de 20 años acude por dolor en hipogastrio de 3 días de evolución y secreción vaginal amarillenta. Al examen ginecológico se constata dolor intenso al movilizar el cuello uterino hacia ambos lados (signo de Frenkel positivo) y a la palpación profunda de ambos anexos. La temperatura axilar es de 38.5°C. El test de embarazo en orina es negativo. No se palpan masas pélvicas y no hay signos de irritación peritoneal difusa. La paciente tolera adecuadamente los líquidos orales. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano ambulatorio completo más adecuado según las guías clínicas del MINSAL?**

A) Ciprofloxacino oral 500 mg cada 12 horas por 7 días como monoterapia
B) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única MÁS Doxiciclina 100 mg cada 12 horas oral por 14 días MÁS Metronidazol 500 mg cada 12 horas oral por 14 días
C) Amoxicilina con ácido clavulánico oral 875/125 mg cada 12 horas por 7 días
D) Metronidazol 2 g oral en dosis única exclusivamente
E) Gentamicina intramuscular 160 mg dosis única y reposo

PREGUNTA 57 3.02.1.011

57. **¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas una paciente con diagnóstico clínico de Enfermedad Pélvica Inflamatoria DEBE ser OBLIGATORIAMENTE HOSPITALIZADA para recibir tratamiento antibiótico parenteral por vía endovenosa?**

A) Paciente de 24 años con EIP leve (Monif I) y buena tolerancia oral
B) Presencia de un Absceso Tubo-Ovárico (ATO) evidenciado en la ecografía transvaginal
C) Paciente con antecedentes de un episodio de EIP hace dos años ya resuelto
D) Paciente con cultivo positivo para Ureaplasma urealyticum en cuello uterino
E) Paciente con pareja sexual que se niega a recibir tratamiento preventivo

PREGUNTA 58 3.02.1.011

58. **Una paciente de 25 años en tratamiento ambulatorio por una EIP consulta en la urgencia por persistencia del dolor pélvico al que se agrega dolor agudo en hipocondrio derecho que empeora con la inspiración profunda, semejante a una pleuresía. La ecografía hepática y biliar descarta colelitiasis y muestra líquido fino perihepático. En la laparoscopía se observan adherencias finas 'en cuerdas de violín' entre la cápsula de Glisson hepática y la pared abdominal anterior. ¿Cuál es el diagnóstico de esta complicación?**

A) Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (Perihepatitis por Chlamydia o Gonococo)
B) Hepatitis autoinmune tipo 2
C) Síndrome de Budd-Chiari agudo
D) Absceso hepático amebiano roto
E) Tromboflebitis séptica de la vena porta (Pileflebitis)

PREGUNTA 59 3.02.1.011

59. **Una paciente hospitalizada hace 48 horas por un Absceso Tubo-Ovárico de 8 cm en tratamiento con Clindamicina más Gentamicina endovenosa presenta súbitamente dolor abdominal difuso hiperagudo de intensidad 10/10, palidez profusa, taquicardia de 130 lpm, presión arterial de 80/40 mmHg y abdomen difusamente en tabla con signos de Blumberg y Guéneau de Mussy generalizados. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta médica inmediata que salva la vida de la paciente?**

A) Apendicitis perforada; colonoscopía de urgencia
B) Rotura de Absceso Tubo-Ovárico (Monif IV) con shock séptico; traslado inmediato a pabellón para laparotomía exploradora de urgencia
C) Embolia pulmonar; inicio inmediato de anticoagulación con heparina
D) Evolución esperable del ATO; aumentar la dosis de gentamicina y esperar 24 horas
E) Hemorragia digestiva alta; endoscopía digestiva alta

PREGUNTA 60 3.02.1.012

60. **Una paciente de 51 años con antecedentes de histerectomía total por miomatosis hace 3 años consulta por bochornos intensos e insomnio que afectan severamente su calidad de vida tras cesar sus síntomas ováricos hace 1 año. No tiene antecedentes oncológicos personales ni familiares, y su mamografía reciente es normal (BI-RADS 2). ¿Cuál es el esquema de Terapia de Reemplazo Hormonal de elección para esta paciente?**

A) Estrógenos solos en monoterapia (vía oral o transdérmica)
B) Estrógenos combinados con progesterona micronizada continua
C) Progestágenos solos a altas dosis
D) Moduladores selectivos de receptores androgénicos exclusivamente
E) Está formalmente contraindicada cualquier hormona por el antecedente de histerectomía

PREGUNTA 61 3.02.1.012

61. **¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas constituye una CONTRAINDICACIÓN FORMAL ABSOLUTA para la prescripción de Terapia de Reemplazo Hormonal sistémica en una mujer con síntomas climatéricos?**

A) Antecedente personal tratado de Cáncer de Mama ductal infiltrante
B) Osteoporosis densitométrica con T-score de -2.8
C) Atrofia vulvovaginal sintomática con dispareunia
D) Edad menor a 45 años con menopausia quirúrgica
E) Sofocos moderados en una mujer de 50 años sana

PREGUNTA 62 3.01.1.013

62. **Una paciente de 34 años consulta por genitorragia y sinusorragia, por lo que se realiza una especuloscopía, que muestra una lesión cervical ulcerada, friable. La conducta más adecuada es:**

A) Colposcopía y biopsia
B) Conización cervical
C) Seguimiento ecográfico
D) Citología cervical
E) Buscar virus papiloma humano

PREGUNTA 63 3.01.1.013

63. Una paciente de 32 años se realizó un PAP hace dos años, que fue informado como "probable NIE 2", sin embargo no tuvo controles posteriores. Hace un mes comienza con genitorragia escasa e intermitente, asociada a mal olor genital. Se realiza una especuloscopía, que visualiza una lesión de 2 cm de diámetro, en relación al cuello uterino, ulcerada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el PAP en este momento
B) Realizar biopsia de cuello uterino
C) Realizar histerectomía radical
D) Realizar un cono cervical
E) Solicitar prueba de detección y tipificación de virus papiloma humano

PREGUNTA 64 3.01.1.013

64. Mujer con PAP con NIE III hace 3 años, sin controles, ahora con lesión exofítica ulcerada en cuello uterino. ¿Cuál es la conducta?

A) Colposcopía y tratamiento inmediato
B) CONO diagnóstico-terapéutico
C) Biopsia cervical
D) Histerectomía total
E) Repetir PAP y controlar en 3 meses

PREGUNTA 65 3.01.1.016

65. Una paciente de 35 años, multípara de 1, se realiza PAP de control, que es informado como presencia de atipias escamosas de significado incierto (ASC-US). Su especuloscopía es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar colposcopía y biopsia cervical
B) Solicitar reacción de cadena de polimerasa para virus papiloma humano
C) Realizar diatermocoagulación cervical
D) Realizar histerectomía
E) Realizar biopsia de endometrio

PREGUNTA 66 3.01.1.016

66. Una paciente de 25 años, con antecedente de haber iniciado su vida sexual a los 14 años y, desde entonces, mantener relaciones sexuales, con múltiples parejas, sin utilización de métodos de barrera, se realiza un PAP que es informado como lesión de alto grado. Además, se realiza tipificación de virus papiloma humano, que muestra serotipo de bajo grado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
B) Solicitar nuevo PAP en 6 años
C) Realizar colposcopía y eventual biopsia
D) Realizar conización cervical
E) Realizar histerectomía

PREGUNTA 67 3.01.1.016

67. Una mujer tiene un PAP alterado, por lo que se realiza una colposcopía y biopsia, que es informada como lesión de bajo grado/VPH. ¿A qué evolucionará con mayor probabilidad esta lesión?

A) Involución espontánea
B) NIE 2
C) Carcinoma in situ
D) Condiloma acuminado
E) Cáncer de cuello uterino

PREGUNTA 68 3.01.1.030

68. Una paciente de 58 años consulta por lesiones pruriginosas con descamación en el pezón y la areola derecha de 6 meses de evolución, sin respuesta al tratamiento con an8micó8cos tópicos. Al examen Fsico se observa lo siguiente: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Cáncer inflamatorio de mama
B) Enfermedad de Paget
C) Derma22s de contacto
D) Psoriasis del pezón
E) Mas22s

PREGUNTA 69 3.02.1.013

69. Una paciente de 38 años recibe el resultado de su Papanicolaou de tamizaje rutinario que informa: 'Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado (LIEAG / H-SIL)'. A la especuloscopía el cuello uterino luce sin lesiones exofíticas evidentes y la paciente está asintomática. ¿Cuál es la conducta médica correcta según la normativa GES del MINSAL?

A) Repetir el PAP en 6 meses para confirmar la persistencia de la lesión
B) Notificar GES y derivar inmediatamente a la Unidad de Patología Cervical (UPC) para Colposcopía y biopsia dirigida
C) Prescribir óvulos vaginales de metronidazol con nistatina por 10 días y dar de alta
D) Programar histerectomía total simple por vía laparoscópica de inmediato
E) Administrar vacuna contra VPH como tratamiento curativo de la lesión

PREGUNTA 70 3.02.1.013

70. Una paciente de 49 años consulta por sangrado genital postcoital y fetidez vaginal de 3 meses. Al examen ginecológico con espéculo se observa un tumor ulcerado y vegetante de 4 cm en el cuello uterino. Al tacto rectovaginal se palpa que la induración tumoral se extiende y compromete de forma evidente el tercio medial del parametrio izquierdo, sin alcanzar la pared ósea pélvica. La biopsia confirma Carcinoma Epidermoide Invasor de cuello uterino (Estadio IIB de la FIGO). ¿Cuál es el tratamiento de elección indicado?

A) Histerectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral (Operación de Wertheim-Meigs)
B) Conización cervical con márgenes amplios
C) Quimiorradioterapia concomitante (Radioterapia externa + Braquiterapia + Cisplatino semanal)
D) Histerectomía total simple extrafascial
E) Tratamiento exclusivamente sintomático y cuidados paliativos

PREGUNTA 71 3.02.1.013

71. ¿Cuál es la edad y la periodicidad del tamizaje poblacional universal garantizado por el régimen GES para la detección precoz del Cáncer Cervicouterino en Chile mediante el examen de Papanicolaou (PAP)?

A) Anual en todas las mujeres a partir del inicio de la actividad sexual hasta los 80 años
B) Cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años de edad
C) Cada 5 años en mujeres de 50 a 69 años de edad exclusivamente
D) Semestral en mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales orales
E) Única vez en la vida a los 35 años de edad

PREGUNTA 72 3.02.1.013

72. ¿Cuáles son los dos genotipos oncogénicos del Virus del Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo más prevalentes a nivel mundial y en Chile, responsables de más del 70% de los carcinomas invasores de cuello uterino?

A) VPH tipos 6 y 11
B) VPH tipos 16 y 18
C) VPH tipos 1 y 2
D) VPH tipos 42 y 43
E) VPH tipos 5 y 8

BLOQUE 5 ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA

PREGUNTA 73 3.01.1.028

73. Una paciente de 70 años consulta por dolor abdominal, de intensidad progresiva, que inició hace 4 meses. Ha bajado 5 kilogramos de peso. Al examen físico se observa abdomen distendido y destaca una masa anexial de 7 cm, de consistencia aumentada. El diagnóstico más probable es:

A) Quiste funcional
B) Mioma uterino
C) Cáncer de ovario
D) Cáncer de colon
E) Endometriosis

PREGUNTA 74 3.01.1.029

74. Una paciente de 24 años se autopalpa un nódulo mamario de 2 cm, indolora, que no está adherida a la piel ni a planos profundos. Se solicita una ecografía mamaria que muestra una lesión bien delimitada, de 25 mm de diámetro, homogénea, con una fina pared que la rodea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste mamario
B) Fibroadenoma
C) Cáncer de mama
D) Papiloma mamario
E) Tumor filoides

PREGUNTA 75 3.02.1.014

75. Una paciente de 52 años asintomática se realiza una mamografía de tamizaje rutinario que informa: 'En el cuadrante superoexterno de la mama izquierda se observa un nódulo espiculado de 15 mm con microcalcificaciones heterogéneas agrupadas en su interior, clasificado como BI-RADS 4C'. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de primera línea indicada a continuación?

A) Control mamográfico estricto a los 6 meses para evaluar estabilidad
B) Realización de Biopsia con aguja gruesa (Core Biopsy) guiada por imágenes
C) Mastectomía radical de urgencia sin confirmación anatomopatológica previa
D) Punción con aguja fina (PAAF) para estudio citológico exclusivo
E) Administración empírica de tamoxifeno oral durante 3 meses

PREGUNTA 76 3.02.1.014

76. Una mujer de 58 años es sometida a una tumorectomía conservadora de mama con márgenes quirúrgicos libres por un carcinoma ductal infiltrante de 18 mm. ¿Cuál de las siguientes terapias adyuvantes locales es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIA tras una cirugía conservadora de mama para reducir la tasa de recidiva local al mismo nivel que una mastectomía total?

A) Radioterapia externa sobre la glándula mamaria restante
B) Quimioterapia con metotrexato intratecal
C) Vaciamiento ganglionar axilar radical bilateral
D) Inyecciones locales de interferón alfa intralesional
E) Ninguna, la cirugía conservadora con bordes libres no requiere tratamientos adicionales

PREGUNTA 77 3.02.1.014

77. Una paciente de 46 años, no lactante, consulta por la salida espontánea de secreción serohemática (líquido rosado con estrías de sangre) por un único poro del pezón de la mama derecha desde hace 3 semanas. A la palpación física no se identifican nódulos dominantes ni adenopatías axilares. ¿Cuál es la causa etiológica benigna más frecuente de este tipo de telorrea?

A) Fibroadenoma mamario simple
B) Papiloma intraductal solitario
C) Prolactinoma hipofisario
D) Mastitis granulomatosa idiopática
E) Ectasia ductal senil

PREGUNTA 78 3.02.1.014

78. Una paciente de 42 años diagnosticada de cáncer de mama invasor presenta el siguiente informe de inmunohistoquímica tumoral: Receptores de Estrógeno (RE) negativos (0%), Receptores de Progesterona (RP) negativos (0%) y HER2 negativo (Score 0). ¿A qué subtipo molecular corresponde este tumor y cuál es la implicancia terapéutica respecto a la hormonoterapia y anticuerpos monoclonales anti-HER2?

A) Subtipo Luminal A; responderá excelentemente a Tamoxifeno como única terapia
B) Subtipo Triple Negativo; NO responderá a hormonoterapia ni a Trastuzumab, requiriendo quimioterapia citotóxica
C) Subtipo HER2 enriquecido; indicación prioritaria de Trastuzumab con Pertuzumab
D) Subtipo Luminal B; requiere monoterapia con inhibidores de aromatasa
E) Carcinoma basocelular de la mama; solo requiere seguimiento sin fármacos

PREGUNTA 79 3.01.1.024

79. Una mujer de 65 años, nulípara, con IMC de 33, sin síntomas, se realiza un PAP que muestra abundantes células endometriales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Controlar con nuevo PAP en un año
B) Indicar estrógenos tópicos
C) Solicitar colposcopía y biopsia
D) Realizar curejate endocervical
E) Solicitar ecografía transvaginal

PREGUNTA 80 3.01.1.024

80. Paciente de 40 y tantos años con uso de ACO, suspendidos hace 2 semanas por gastritis. Inicia con sangrado hace 3 días?, eco con endometrio de 10 mm heterogéneo. Conducta más adecuada:

A) Suspender ACO y controlar en 3 meses
B) Legrado biópsico en pabellón
C) Biopsia aspirativa de forma ambulatoria.
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

PREGUNTA 81 3.01.1.024

81. Una paciente de 56 años, en tratamiento con tamoxifeno 20 mg/día, por un cáncer de mama, diagnosticado hace 9 años, presenta metrorragia escasa desde hace 5 días, por lo que se solicita una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 8 mm, sin alteraciones anexiales. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar terapia de reemplazo hormonal oral
B) Instalar dispositivo intrauterino medicado
C) Disminuir la dosis de tamoxifeno
D) Solicitar biopsia endometrial
E) Realizar histerectomía

PREGUNTA 82 3.01.1.024

82. Una mujer de 62 años, con antecedente de 2 episodios de metrorragia autolimitada, en los últimos 3 meses, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 10 mm de grosor. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar anticonceptivos orales
B) Realizar estudio de alteraciones de la hemostasia
C) Solicitar resonancia magnética de pelvis
D) Realizar biopsia endometrial
E) Observar evolución

PREGUNTA 83 3.01.1.024

83. Postmenopáusica con metrorragia y endometrio de 18 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Ecografía transvaginal en 3 meses
B) Histeroscopía diagnóstica
C) Legrado uterino bajo anestesia
D) Iniciar gestágenos y controlar
E) Solicitar biopsia endometrial

PREGUNTA 84 3.02.1.015

84. Una paciente de 63 años consulta por sangrado vaginal rojo oscuro escaso de 2 semanas de evolución tras 12 años de amenorrea menopáusica. La ecografía transvaginal muestra un grosor endometrial de 12 mm, heterogéneo e irregular. ¿Cuál es el paso diagnóstico que debe realizarse de inmediato?

A) Prescribir óvulos de estriol vaginal durante 1 mes y reevaluar con ecografía
B) Realización de una Biopsia Endometrial (mediante cánula de Pipelle o histeroscopía)
C) Solicitar tomografía por emisión de positrones (PET-CT) de cuerpo entero
D) Indicar reposo en cama y control ecográfico en 6 meses
E) Realizar laparoscopía exploradora diagnóstica para ooforectomía bilateral

PREGUNTA 85 3.02.1.015

85. Una mujer de 65 años consulta por distensión abdominal progresiva, dispepsia y saciedad precoz de 3 meses de evolución. Al examen físico se palpa abdomen distendido con matidez desplazable compatible con ascitis y una masa pelviana profunda firme. La ecografía transvaginal muestra una masa anexial derecha de 9 cm, multiloculada, con septos gruesos de 5 mm, abundantes proyecciones papilares sólidas internas con vascularización Doppler central de baja resistencia, y abundante líquido libre ascítico en fondo de saco de Douglas. El marcador sérico CA-125 resulta en 450 U/mL (VN < 35 U/mL). ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable y la conducta adecuada?

A) Quiste folicular funcional simple; indicar anticonceptivos orales por 3 meses
B) Cáncer epitelial de ovario avanzado; derivar de inmediato a Ginecología Oncológica para laparotomía etapificadora y citorreducción primaria
C) Punción transvaginal evacuadora del quiste ovárico para aliviar la presión
D) Endometrioma ovárico; prescribir dienogest oral continuo
E) Absceso apendicular crónico; apendicectomía electiva ambulatoria

PREGUNTA 86 3.02.1.015

86. ¿Por qué razón oncológica fundamental está FORMALMENTE CONTRAINDICADO realizar una punción-aspiración con aguja de una masa anexial ovárica con criterios ecográficos sospechosos de malignidad?

A) Porque induce una hemorragia digestiva masiva secundaria
B) Porque la rotura de la cápsula quística provoca la siembra y diseminación de células malignas en la cavidad peritoneal, empeorando el estadio y pronóstico oncológico de la paciente
C) Porque eleva de forma irreversible los niveles plasmáticos de CA-125
D) Porque provoca el cierre precoz de las trompas de Falopio contralaterales
E) Porque desencadena una crisis de tirotoxicosis autoinmune

PREGUNTA 87 3.02.1.015

87. ¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas se asocia al mayor riesgo relativo de desarrollar un Adenocarcinoma de Endometrio de tipo I endometrioide debido a la estimulación estrogénica continua no balanceada?

A) Multiparidad con más de 4 hijos
B) Uso prolongado de anticonceptivos orales combinados durante más de 10 años
C) Obesidad severa (aromatización periférica en tejido adiposo) y Síndrome de Ovario Poliquístico
D) Tabaquismo crónico activo de más de 20 cigarrillos al día
E) Uso continuo de dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

PREGUNTA 88 3.01.2.019

88. Una paciente de 30 años consulta por dolor en la fosa iliaca derecha, que se ha asociado a vómitos alimentarios y que inició hace 48 horas. Al examen físico T°: 36°C, FC: 110x', PA: 110/70 mmHg. El examen abdominal muestra resistencia muscular involuntaria a la palpación de la fosa ilíaca derecha, con ruidos hidroaéreos conservados. Se realiza tacto vaginal, que resulta inconcluso debido a resistencia muscular. Se solicita una ecografía ginecológica transvaginal, que visualiza un tumor anexial derecho quístico multiloculado, de 10 cm de diámetro, con ausencia de flujo al Doppler color. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Apendicitis aguda
B) Embarazo ectópico
C) Proceso inflamatorio pélvico
D) Tumor anexial torcido
E) Cáncer de ovario

PREGUNTA 89 3.02.1.016

89. Una joven de 21 años consulta por dolor intenso y súbito en fosa ilíaca izquierda de 5 horas de evolución que se acompaña de náuseas y múltiples vómitos alimentarios. La prueba de embarazo es negativa. La ecografía transvaginal Doppler revela un ovario izquierdo aumentado de volumen a 7 cm con estroma marcadamente edematoso y ausencia de flujo vascular al Doppler color, visualizándose el 'signo del remolino' en el pedículo. ¿Cuál es el tratamiento médico-quirúrgico inmediato más adecuado?

A) Prescribir analgesia con ketorolaco endovenoso y enviar a reposo en domicilio
B) Laparoscopía de urgencia inmediata para detorsión ovárica y preservación del anexo
C) Punción transvaginal evacuadora guiada por ecografía
D) Tratamiento antibiótico endovenoso para enfermedad pélvica inflamatoria
E) Ooforectomía radical izquierda abierta sin desenrollar el ovario

PREGUNTA 90 3.02.1.016

90. Una paciente de 24 años consulta por dolor pélvico agudo de inicio brusco tras mantener relaciones sexuales coitales hace 3 horas. Se encuentra en el día 23 de su ciclo menstrual (fase lútea tardía). Signos vitales: PA 118/74 mmHg, FC 78 lpm, afebril. Abdomen blando, sensible en fosa ilíaca derecha sin signos peritoneales. La prueba rápida de embarazo es negativa. La ecografía transvaginal muestra una imagen quística ovárica derecha de 3.5 cm con múltiples septos finos reticulares en 'red de pesca' y escaso líquido libre anecoico en el fondo de saco de Douglas. Su hematocrito es de 40% y se mantiene estable tras 4 horas de observación. ¿Cuál es la conducta médica indicada?

A) Laparotomía exploradora de urgencia para ooforectomía derecha
B) Manejo médico conservador expectante con analgesia oral, reposo y control ambulatorio
C) Cistectomía ovárica laparoscópica inmediata
D) Inicio de quimioterapia con metotrexato parenteral
E) Transfusión inmediata de 2 unidades de glóbulos rojos

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: A

Dolor pelviano y dismenorrea

3.01.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Dolor pelviano y dismenorrea" (3.01.1.014), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 2 Respuesta: D

Pelviperitonitis

3.01.2.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un proceso inflamatorio pélvico (PIP) clásico, también llamado enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) o pelviperitoniGs cuando hay signos de compromiso peritoneal. Se debe estudiar con una ecografía TV para descartar abscesos tubo ováricos. Además, se debe tratar con antibióticos de amplio espectro. No es necesario reGrar el DIU, a menos que no responda en 48 horas de antibioterapia o que además del PIP se confirme la presencia de Ac9nomyces.

PREGUNTA 3 Respuesta: A

Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

3.01.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome de Asherman: El caso corresponde a un síndrome de Asherman clásico, también llamado sinequias uterinas, causado por un legrado uterino. En la ecografía transvaginal se suele ver con endometrio fino. Se trata con cirugía.

PREGUNTA 4 Respuesta: B

Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

3.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En la falla ovárica prematura no hay estrógenos para proliferar el endometrio, por lo que el test de progesterona resulta negativo. B) Correcta. El Test de Progesterona consiste en administrar un progestágeno durante 5 a 10 días para inducir la maduración secretora del endometrio y posterior descamación por deprivación. Si la paciente sangra (Test Positivo), significa con absoluta certeza que su organismo produce cantidades suficientes de Estrógenos endógenos para preparar y proliferar el endometrio, pero no produce progesterona propia debido a la ausencia de cuerpo lúteo, lo que define un estado de Anovulación crónica (la causa más frecuente en mujeres jóvenes es el Síndrome de Ovario Poliquístico). C) Incorrecta. Si hubiera estenosis cervical la sangre no podría exteriorizarse por la vagina. D) Incorrecta. En el síndrome de Asherman no hay endometrio funcionante y el test de progesterona es estrictamente negativo. E) Incorrecta. En el hipogonadismo hipogonadotropo no hay estímulo ovárico ni estrógenos.

PREGUNTA 5 Respuesta: C

Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

3.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En el síndrome de Rokitansky el cariotipo es 46,XX y el vello pubiano y axilar es completamente normal. B) Incorrecta. El Turner tiene cariotipo 45,X0, talla baja y mamas no desarrolladas. C) Correcta. El Síndrome de Morris (Feminización Testicular o Insensibilidad a los Andrógenos) es una entidad con cariotipo 46,XY caracterizada por la mutación del receptor de andrógenos. Los testículos fetales producen testosterona y hormona antimülleriana (AMH); la AMH produce regresión de los conductos de Müller (por lo que NO hay útero ni tercio superior de vagina). Debido a la insensibilidad androgénica periférica completa, los genitales externos se desarrollan con fenotipo femenino y NO se desarrolla vello púbico ni axilar (signo patognomónico). La testosterona circulante se aromatiza periféricamente a estrógenos, generando un excelente desarrollo de mamas. Las masas inguinales corresponden a los testículos ectópicos, los cuales deben extirparse tras completar la pubertad por riesgo de neoplasia (gonadoblastoma/seminoma). D) Incorrecta. En Swyer no hay desarrollo mamario (mamas infantiles por falta de estrógenos) y sí tienen útero. E) Incorrecta. Provoca virilización de genitales en fetos 46,XX.

PREGUNTA 6 **Respuesta: B**

Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

3.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La RMN sella se solicita ante hiperprolactinemia, pero aquí el problema es endometrial. B) Correcta. El fracaso en presentar sangrado por deprivación tras el ciclo combinado de estrógenos más progesterona demuestra que el endometrio no responde o existe una obliteración mecánica del canal uterino. En una paciente con antecedente reciente de legrado uterino, este hallazgo es patognomónico del Síndrome de Asherman (sinequias o adherencias intrauterinas cicatriciales que obliteran la cavidad endometrial). El estándar de oro diagnóstico y terapéutico indiscutido es la Histeroscopía, la cual permite visualizar directamente las bridas y realizar la lisis quirúrgica de las mismas. C) Incorrecta. El cariotipo es para amenorreas primarias. D) Incorrecta. La TAC no tiene resolución para sinequias endometriales. E) Incorrecta. La AMH evalúa reserva ovárica, no la cavidad uterina.

PREGUNTA 7 **Respuesta: B**

Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

3.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El Turner tiene FSH marcadamente elevada por falla ovárica gonadal, no baja, y no tiene anosmia. B) Correcta. La asociación patognomónica de hipogonadismo hipogonadotropo (FSH y LH muy disminuidas con falta de desarrollo puberal) y Anosmia o Hiposmia congénita define el Síndrome de Kallmann. Se debe a un defecto genético en la migración embrionaria de las neuronas secretoras de GnRH y de las neuronas del bulbo olfatorio desde la placoda olfatoria hacia el hipotálamo. C) Incorrecta. El craneofaringioma produce cefalea, alteraciones del campo visual (hemianopsia) y diabetes insípida, no anosmia congénita aislada. D) Incorrecta. La falla ovárica cursa con FSH elevada. E) Incorrecta. En Rokitansky el eje gonadotropo es normal y las pacientes tienen excelente desarrollo mamario.

PREGUNTA 8 **Respuesta: B**

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo

3.01.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene síntomas climatéricos, que se tratan con terapia de reemplazo hormonal. La regla general es que se usan estrógenos más progestágenos, salvo en las pacientes histerectomizadas, en que se usa estrógeno solo. En este caso tiene útero, ya que tiene reglas irregulares. En los casos en que la TRH está contraindicada (ej. cáncer de mama) se usan los antidepresivos, ya sea IRS o venlafaxina. En la práctica, suele indicarse de tipo continua, ya que no sirve mayormente la TRH cíclica (aunque hay quienes postulan que sirve en el inicio de los síntomas climatérico, como una forma de ciclar a la paciente con reglas irregulares; sin embargo, en la práctica casi no existen fármacos de ese tipo disponibles en el medio chileno, salvo que use ACOs como TRH).

PREGUNTA 9 **Respuesta: B**

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo

3.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El clomifeno se utiliza para inducir ovulación en mujeres que desean embarazarse activamente. B) Correcta. La paciente cumple con los tres criterios de Rotterdam para SOP (oligomenorrea, hiperandrogenismo clínico y morfología ovárica ecográfica policística). En mujeres que no buscan fertilidad, la primera línea farmacológica según las guías internacionales y del MINSAL son los Anticonceptivos Orales Combinados (ACOs) con progestágeno antiandrogénico (Dienogest, Drospirenona o Acetato de Ciproterona). Los ACOs reducen la secreción de LH, elevan la SHBG plasmática (disminuyendo la testosterona libre circulante, lo que mejora el acné y el hirsutismo) y regularizan las descamaciones endometriales, previniendo el desarrollo de hiperplasia endometrial. C) Incorrecta. Los corticoides no son el tratamiento del SOP. D) Incorrecta. La cirugía de resección ovárica está en desuso por riesgo de adherencias pelvianas e insuficiencia ovárica. E) Incorrecta. El danazol es androgénico y empeoraría el hirsutismo.

PREGUNTA 10 **Respuesta: B**

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo

3.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El CCU depende de la infección persistente por VPH, no de la anovulación. B) Correcta. En el SOP, la anovulación crónica persistente provoca una ausencia prolongada de cuerpo lúteo y, por ende, de progesterona. Esto genera un ambiente hormonal caracterizado por la presencia continua de estrógenos libres que estimulan de forma ininterrumpida la proliferación celular del endometrio sin la acción maduradora y antiproliferativa de la progesterona ('estrógenos sin oposición'). Con los años, esta hiperproliferación conduce sucesivamente a hiperplasia endometrial simple, hiperplasia endometrial con atipias y finalmente a Adenocarcinoma de Endometrio de tipo I (endometrioide), con un riesgo de 3 a 5 veces superior al de mujeres ovuladoras. C) Incorrecta. El cáncer epitelial de ovario se relaciona con mayor número de ovulaciones incesantes (el SOP es anovulatorio). D) Incorrecta. Es un tumor trofoblástico postgestacional. E) Incorrecta. Neoplasia mesenquimatosa no vinculada al SOP.

PREGUNTA 11 **Respuesta: E**

Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

3.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 5). Evalúa el manejo clínico de Hemorragia genital anormal según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 12 **Respuesta: D**

Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

3.01.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Miomas sintomáticos en mujer sin hijos: miomectomía. Cierto es que los miomas intramurales suelen ser asintomáticos, pero en este caso se debe simplificar la pregunta a ¿cuál es el tratamiento de los miomas con hipermenorrea?

PREGUNTA 13 **Respuesta: B**

Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

3.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Instalar un DIU-LNG sin descartar previamente malignidad en una mujer de 47 años con endometrio engrosado puede retrasar catastróficamente el diagnóstico de un adenocarcinoma endometrial. B) Correcta. Según los consensos internacionales (FIGO, ACOG) y las directrices del MINSAL, toda mujer de 45 años o más que consulte por Sangrado Uterino Anormal tiene indicación mandatoria de Biopsia Endometrial (mediante cánula de Pipelle ambulatoria o histeroscopía) para descartar cáncer de endometrio o hiperplasia endometrial con atipias antes de definir o iniciar un tratamiento médico hormonal definitivo. C) Incorrecta. La histerectomía es desproporcionada y prematura sin un diagnóstico histopatológico previo. D) Incorrecta. El ácido tranexámico solo controla el síntoma pero no descarta malignidad. E) Incorrecta. Observar en una paciente perimenopáusica con sangrado abundante es negligencia médica.

PREGUNTA 14 **Respuesta: B**

Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

3.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La adenomiosis es excepcional en adolescentes y propia de multíparas sobre 35 años. B) Correcta. Dentro de la clasificación PALM-COEIN, la letra 'C' corresponde a Coagulopatías. La Enfermedad de von Willebrand es la coagulopatía hereditaria más común y se diagnostica en hasta un 20% de las adolescentes que ingresan hospitalizadas por hipermenorrea severa desde su menarquia, especialmente si se acompaña de historia de sangrado mucocutáneo (epistaxis, equimosis, gingivorragia). Debe solicitarse estudio de hemostasia completo (antígeno de vWF, actividad de cofactor de ristocetina y factor VIII). C) Incorrecta. El cáncer endometrial es extraordinariamente infrecuente a los 14 años. D) Incorrecta. Los pólipos son causas estructurales raras en la adolescencia. E) Incorrecta. Los miomas son típicos de mujeres en la 4.ª y 5.ª década de la vida.

PREGUNTA 15 **Respuesta: B**

Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

3.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La aspirina es un antiagregante plaquetario que aumenta el sangrado. B) Correcta. El Dispositivo Intrauterino liberador de Levonorgestrel (DIU-LNG / Mirena) es el tratamiento farmacológico no quirúrgico más eficaz disponible en la medicina actual para el SUA no estructural. Al liberar diariamente levonorgestrel directamente en la cavidad uterina, produce una intensa decidualización del estroma y una atrofia endometrial marcada y reversible, reduciendo la pérdida sanguínea menstrual en más de un 90% a los 6 meses, superando con creces a cualquier terapia oral y evitando histerectomías en un alto porcentaje de pacientes. C) Incorrecta. El DIU de cobre tiene como efecto secundario común el AUMENTO del sangrado menstrual y la dismenorrea. D) Incorrecta. Los progestágenos orales continuos son eficaces pero inferiores al DIU-LNG en adherencia y reducción neta. E) Incorrecta. La vitamina K solo es útil en coagulopatías por déficit de factores dependientes o sobredosis de cumarínicos.

PREGUNTA 16 **Respuesta: A**

Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

3.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. El sangrado uterino en una mujer postmenopáusica es un síntoma de alarma neoplásico hasta que se demuestre lo contrario. Aunque la atrofia endometrial es la causa más frecuente en número de casos, el Cáncer de Endometrio es la causa maligna subyacente en el 10 al 15% de las pacientes. Un grosor endometrial ecográfico ≥ 4 a 5 mm en una postmenopáusica exige de forma mandatoria la toma de una Biopsia Endometrial para estudio histopatológico definitivo. B) Incorrecta. Aunque la vaginitis atrófica es frecuente, un endometrio de 9 mm (> 4-5 mm) prohíbe atribuir el sangrado a atrofia sin biopsia. C) Incorrecta. Administrar hormonas a ciegas sobre un eventual adenocarcinoma retrasa el tratamiento curativo. D) Incorrecta. Conducta negligente ante metrorragia de la postmenopausia. E) Incorrecta. La cirugía de ovario no diagnostica el sangrado uterino.

PREGUNTA 17 **Respuesta: A**

Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis

3.01.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Hiperplasia Endometrial: El endometrio grueso e irregular es una característica tanto de la hiperplasia endometrial como del cáncer de endometrio. Sin embargo, la descripción de un aspecto heterogéneo con áreas microquísticas se observa con mayor frecuencia en la hiperplasia endometrial, por lo que esta es la respuesta correcta. Eso sí, la conducta es realizar una biopsia de endometrio para confirmar el diagnóstico y descartar el cáncer. La hiperplasia simple se trata con progestágenos. La hiperplasia atípica, en cambio, se trata con histerectomía.

PREGUNTA 18 **Respuesta: B**

Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis

3.02.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La histerectomía mutilaría definitivamente su deseo de fertilidad. B) Correcta. En una paciente con deseo de embarazo que presenta un mioma submucoso intracavitario (FIGO 0 o 1) menor de 4-5 cm que causa sangrado o distorsión de la cavidad endometrial, el tratamiento de elección indiscutido es la Miomectomía por Histeroscopía quirúrgica resectoscópica. Es un procedimiento mínimamente invasivo, ambulatorio y conservador que extirpa el mioma respetando la pared miometrial y restaurando la anatomía endometrial y la fertilidad. C) Incorrecta. La embolización de arterias uterinas puede comprometer la reserva ovárica y aumentar complicaciones obstétricas posteriores, por lo que está formalmente desaconsejada en mujeres con deseo de gestación. D) Incorrecta. Los análogos de GnRH solo se usan por un máximo de 3-6 meses como puente quirúrgico, no como terapia definitiva por riesgo de osteoporosis severa. E) Incorrecta. Los miomas son benignos y la radioterapia no tiene indicación.

BLOQUE 2 ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: D**

Enfermedades de transmisión sexual

3.01.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Condilomas acuminados genitales en embarazo: La imagen muestra condilomas acuminados, causados por el virus del papiloma humano (VPH), serotipos 6 y 11. A diferencia del herpes genital, los condilomas acuminados no contraindican el parto vaginal. El tratamiento de elección durante el embarazo es el ácido tricloroacético tópico. Otros tratamientos tópicos como el imiquimod y el podofilino, aunque eficaces para tratar los condilomas acuminados, están contraindicados durante el embarazo.

PREGUNTA 20 **Respuesta: C** **Mastitis abscedada** 3.01.2.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 64). Evalúa el manejo clínico de Mastitis abscedada según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 21 **Respuesta: E**

Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

3.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Adenomiosis: endometrio ectópico dentro del miometrio → útero grande, globuloso, heterogéneo en ecografía + dismenorrea severa + menometrorragia + dispareunia. Afecta mujeres multíparas >35 años. Tratamiento: AINEs, gestágenos, DIU hormonal o histerectomía.

PREGUNTA 22 **Respuesta: A**

Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

3.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Endometriosis.

PREGUNTA 23 **Respuesta: B**

Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

3.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un endometrioma clásico, tanto por la clínica como por la imagen. Además, tiene la elevación del Ca-125, que, si bien es un marcador de cáncer de ovario, se eleva en otros procesos peritoneales, como la endometriosis.

PREGUNTA 24 **Respuesta: C**

Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

3.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una pregunta muy discuGble. La clínica orienta fuertemente a una endometriosis (dismenorrea secundaria, progresiva y refractaria), cuyo examen diagnóstico de elección es la laparoscopía (que también es terapéutica) y quien redactó la pregunta probablemente buscaba evaluar la capacidad de reconocer el cuadro clínico de la endometriosis. Sin embargo, aunque no está en las opciones, se recomienda iniciar el estudio con ecografía (que suele estar normal, salvo que haya un endometrioma) y también es correcto tratarla con anticonceptivos orales, ya que atrofian la endometriosis y no Genen el riesgo quirúrgico, por lo que muchas guías internacionales dejan la laparoscopía reservada a 1. No responde a AINES + ACO, 2. InferGlidad y 3. Endometrioma. De todos modos, en este caso, por la severidad de los síntomas y lo ya explicado, dejaremos como correcta la laparoscopía.

PREGUNTA 25 **Respuesta: A**

Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

3.01.2.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un cuerpo lúteo heorrágico clásico.

PREGUNTA 26 **Respuesta: B**

Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

3.02.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Los analgésicos simples son totalmente insuficientes para una endometriosis sintomática. B) Correcta. En pacientes con endometriosis y dolor pélvico (dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico) que NO desean fertilidad activa inmediata, el tratamiento médico de primera línea de elección respaldado por las guías clínicas internacionales (ESHRE) y el MINSAL es el uso continuo de Progestágenos, siendo el DIENOGEST oral a dosis de 2 mg al día el estándar de oro actual. El dienogest produce decidualización y atrofia directa de las lesiones endometriósicas ectópicas, suprime la ovulación y reduce la inflamación pélvica de forma segura y prolongada. C) Incorrecta. El metotrexato es para el embarazo ectópico. D) Incorrecta. El clomifeno estimula la foliculogénesis e induciría mayor crecimiento estrogénico de los implantes. E) Incorrecta. Los estrógenos solos alimentarían y proliferarían agresivamente las lesiones de endometriosis.

PREGUNTA 27 **Respuesta: B**

3.02.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

A) Incorrecta. El cistoadenocarcinoma seroso muestra áreas sólidas, septos gruesos, papilas internas y ascitis con alta vascularización Doppler. B) Correcta. La descripción ecográfica clásica y patognomónica de una masa quística unilocular ovárica con ecos internos finos y homogéneos de bajo nivel descrita como imagen en 'vidrio esmerilado' (ground glass appearance), con pared regular y sin vascularización Doppler interna en una mujer joven con dolor pélvico e infertilidad, corresponde con total precisión a un Endometrioma Ovárico (o 'quiste de chocolate'). C) Incorrecta. El teratoma muestra nódulos ecogénicos murales (tapón de Rokitansky), niveles líquido-grasa y áreas de sombra acústica por calcificaciones o dientes. D) Incorrecta. El quiste folicular es anecoico puro, con refuerzo acústico posterior y sin ecos internos. E) Incorrecta. El absceso tubo-ovárico es una masa compleja multiloculada dolorosa con paredes engrosadas y Doppler hiperémico.

PREGUNTA 28 **Respuesta: B**

3.02.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

A) Incorrecta. No son teratogénicos irreversibles. B) Correcta. La evidencia médica basada en ensayos clínicos aleatorizados y guías internacionales (ESHRE / ASRM) ha demostrado de forma categórica que la supresión médica hormonal de la endometriosis (con ACOs, progestágenos, análogos de GnRH o danazol) NO erradica las adherencias anatómicas ni mejora las tasas acumuladas de embarazo espontáneo tras su retiro, y tiene el efecto deletéreo de anovulación que posterga inútilmente el tiempo reproductivo de la mujer. Ante infertilidad por endometriosis, el camino es la cirugía laparoscópica para reparar la anatomía o la fertilización in vitro (FIV). C) Incorrecta. No ocluyen las trompas. D) Incorrecta. No tienen relación con enfermedad trofoblástica. E) Incorrecta. No aceleran la pérdida folicular.

PREGUNTA 29 **Respuesta: A**

3.02.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

A) Correcta. El cuadro de útero uniformemente aumentado de tamaño, blando y doloroso en una multípara de más de 40 años con hipermenorrea y dismenorrea severa corresponde a una Adenomiosis Uterina (o endometriosis interna). La definición anatomopatológica estricta de la adenomiosis es la presencia de glándulas y estroma endometrial dentro del miometrio a más de 2.5 mm de la capa basal del endometrio, acompañada de hiperplasia e hipertrofia del músculo liso adyacente. B) Incorrecta. Es la definición de mioma. C) Incorrecta. Corresponde a un sarcoma uterino maligno. D) Incorrecta. Es un pólipo cervical. E) Incorrecta. Describe implantes de endometriosis externa peritoneal.

PREGUNTA 30 **Respuesta: C**

3.01.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia

El Prolapso se evalúa con el POP-Q: un examen físico formal, realizado por un ginecólogo, en el cual se mide el grado de prolapso de las distintas estructuras genitales.

PREGUNTA 31 **Respuesta: D**

3.01.1.032 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia

Es una incontinencia de orina de esfuerzos. El orden a tratar es: descartar ITU, luego kinesioterapia pélvica (ejercicios de Koegel) y finalmente la cirugía (suspensión uretral con TOT o TVT).

PREGUNTA 32 **Respuesta: A**

3.02.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia

A) Correcta. La Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) confirmada clínicamente que no responde al tratamiento conservador tiene como estándar de oro quirúrgico indiscutido la colocación de un Cabestrillo Mediouretral Libre de Tensión (Slings tipo TOT [Trans-Obturator Tape] o TVT [Tension-free Vaginal Tape]). Estas cintas de polipropileno se ubican debajo de la uretra media por vía vaginal, restableciendo el soporte suburetral y logrando tasas de continencia y curación superiores al 85-90% con baja morbilidad. B) Incorrecta. La toxina botulínica vesical es para la incontinencia de urgencia severa refractaria, no para la de esfuerzo. C) Incorrecta. La oxibutinina es un anticolinérgico para la hiperactividad del detrusor; en la IUE es ineficaz. D) Incorrecta. Es una cirugía mayor reservada para vejigas neurógenas espásticas de escasa capacidad. E) Incorrecta. Procedimiento en desuso y sin rol en IUE.

PREGUNTA 33 **Respuesta: B**

Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia

3.02.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La cirugía de TOT/TVT está contraindicada en la incontinencia de urgencia porque no trata la hiperactividad del detrusor e incrementa el riesgo de retención urinaria y empeoramiento de la urgencia. B) Correcta. El cuadro clínico de deseo miccional imperioso seguido de escape, acompañado de polaquiuria diurna y nicturia sin esfuerzo asociado corresponde a una Incontinencia Urinaria de Urgencia (Vejiga Hiperactiva). El tratamiento de primera línea no invasivo consiste en medidas higiénico-dietéticas y reeducación vesical con micciones programadas, asociado a tratamiento farmacológico con Antimuscarínicos (Solifenacina, Oxibutinina) para bloquear los receptores colinérgicos del detrusor, o un agonista de receptores beta-3 adrenérgicos (Mirabegrón) que promueve la relajación del detrusor durante el llenado vesical. C) Incorrecta. La restricción extrema de líquidos concentra la orina y estimula aún más el detrusor. D) Incorrecta. No hay estenosis uretral. E) Incorrecta. El sedimento es normal y el uso prolongado de antibióticos genera resistencia innecesaria.

PREGUNTA 34 **Respuesta: B**

Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

3.01.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

De elección es el seguimiento folicular, que no está dentro de las alternativas. El test postcoital requiere de un seguimiento folicular y se le pide que tengan relaciones el día previo a la ovulación (se sabe ese día por el Seguimiento folicular ecográfico), de modo de evaluar el factro cervical además. Los demás exámenes son de segunda o tercera línea

---

PREGUNTA 35 **Respuesta: C**

Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

3.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El semen del esposo es normal y las trompas de la mujer están bloqueadas, por lo que la IIU fracasará independientemente del origen del semen. B) Incorrecta. Las relaciones programadas no sirven si los gametos no pueden encontrarse por la obstrucción física tubárica. C) Correcta. La obstrucción tubárica bilateral no corregible es la indicación clásica y primordial de la Fertilización In Vitro (FIV). La FIV 'bypasea' o salta completamente la necesidad funcional de las trompas de Falopio al aspirar los ovocitos directamente del ovario mediante punción transvaginal, fertilizarlos con los espermatozoides en la placa de cultivo del laboratorio y transferir el embrión resultante directamente a la cavidad endometrial. D) Incorrecta. La Inseminación Intrauterina (IIU) exige como condición indispensable que al menos una trompa esté permeable; al estar ambas bloqueadas, la tasa de éxito de la IIU es del 0%. E) Incorrecta. Los antibióticos no resuelven la fibrosis cicatrizal tubárica establecida.

PREGUNTA 36 **Respuesta: B**

Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

3.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Una abstinencia menor a 48 horas reduce artificialmente el volumen y el recuento total de espermatozoides. B) Correcta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las guías clínicas de fertilidad establecen de forma estricta que la recolección de semen para un espermiograma diagnóstico debe realizarse tras un período mínimo de 2 a 3 días y un máximo de 5 a 7 días de abstinencia sexual previa (la recomendación estándar óptima es de 3 a 5 días). Períodos más cortos disminuyen el volumen y concentración espermática, mientras que períodos más prolongados aumentan el recuento a expensas de una drástica caída en la motilidad y viabilidad de los espermatozoides por envejecimiento celular. C) Incorrecta. Abstinencias muy prolongadas aumentan las formas muertas y detritos. D) Incorrecta. Es el parámetro preanalítico más crítico de estandarización. E) Incorrecta. La recolección seminal masculina no depende del día del ciclo femenino.

BLOQUE 3 — ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A** **Oligoanovulación crónica**

3.01.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Oligoanovulación crónica" (3.01.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 38 **Respuesta: B**

Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso

3.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Absceso vulvar/hematoma infectado post-parto: aumento de volumen azulado + fluctuante + doloroso a las 48h del parto = hematoma infectado o absceso. Requiere drenaje quirúrgico + antibióticos (amoxicilina-clavulánico). El hematoma no infectado (<24h, sin fiebre) se maneja con compresas frías.

PREGUNTA 39 **Respuesta: B**

Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso

3.02.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La punción con aguja tiene una tasa de recidiva superior al 80-90% y está proscrita. B) Correcta. El tratamiento de elección para el absceso agudo de la glándula de Bartolino es la incisión y drenaje amplio seguido de MARSUPIALIZACIÓN (sutura de los bordes de la pared de la cápsula a la mucosa vestibular para formar un ostium permanente permeable), o alternativamente la colocación de un Catéter de Word. Estos procedimientos permiten la evacuación del pus y garantizan la formación de una nueva apertura fistulosa definitiva que previene la reobstrucción y recidiva. C) Incorrecta. La vulvectomía es una cirugía mutilante exclusiva de neoplasias malignas invasoras. D) Incorrecta. Los antibióticos no penetran adecuadamente una colección purulenta cerrada a tensión; el drenaje es imperativo. E) Incorrecta. El nitrato de plata quema la superficie sin resolver la cavidad abscedada profunda.

PREGUNTA 40 **Respuesta: B**

Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso

3.02.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La candidiasis produce eritema inflamatorio agudo y leucorrea en requesón, no atrofia blanquecina esclerosante. B) Correcta. La combinación de prurito vulvar crónico intratable en una mujer postmenopáusica con placas atróficas blanquecinas apergaminadas en forma de cerradura o en ocho, con reabsorción de labios menores y encapuchamiento del clítoris, es la descripción patognomónica del Liquen Escleroso Vulvar. El tratamiento de primera línea respaldado por todas las guías dermatológicas y ginecológicas consiste en la aplicación tópica de Corticoides Ultrapotentes, siendo el ungüento de Propionato de Clobetasol al 0.05% el fármaco de elección para frenar la inflamación autoinmune y aliviar el prurito. C) Incorrecta. Los condilomas son vegetaciones verrugosas exofíticas por VPH. D) Incorrecta. El herpes causa vesículas dolorosas agrupadas que se ulceran. E) Incorrecta. La psoriasis vulvar se manifiesta como placas eritematosas brillantes no atróficas.

PREGUNTA 41 **Respuesta: C**

Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia

3.02.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El DIU de cobre es Categoría 1 (sin ninguna restricción). B) Incorrecta. El implante de etonogestrel contiene solo progestágeno y es Categoría 1 en fumadoras. C) Correcta. De acuerdo a los Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS y a las normas de anticoncepción del MINSAL, ser mujer de 35 años o más y fumar 15 o más cigarrillos al día es una contraindicación formal absoluta (CATEGORÍA 4: Riesgo inaceptable para la salud) para el uso de Anticonceptivos Hormonales Combinados que contengan estrógenos. El sinergismo entre el etinilestradiol y los componentes del tabaco altera severamente la función endotelial y la hemostasia, disparando el riesgo de infarto de miocardio, trombosis venosa y ACV isquémico. D) Incorrecta. El DIU-LNG contiene solo progestágeno local y es totalmente seguro (Categoría 1). E) Incorrecta. La minipíldora de solo progestágeno es Categoría 1 en fumadoras.

PREGUNTA 42 **Respuesta: B**

Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia

3.02.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La mifepristona es un antiprogestágeno utilizado en interrupción del embarazo, no la PAE estándar en Chile. B) Correcta. El método de anticoncepción de emergencia farmacológico de elección en Chile y en los protocolos del MINSAL es el LEVONORGESTREL a dosis única de 1.5 mg por vía oral (o dos comprimidos de 0.75 mg juntos), administrado preferentemente dentro de las primeras 72 horas del coito no protegido. Su mecanismo de acción biológico comprobado consiste en impedir o postergar el pico ovulatorio de LH y la consecuente expulsión del ovocito; NO actúa como un método abortivo, no afecta el endometrio receptivo ni daña un embrión ya implantado. C) Incorrecta. El misoprostol es un abortivo sintético, no anticoncepción de emergencia. D) Incorrecta. El metotrexato es un citotóxico para ectópico. E) Incorrecta. El método de Yuzpe clásico con estrógenos está en desuso por su alta tasa de náuseas y menor eficacia.

PREGUNTA 43 **Respuesta: A**

Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia

3.02.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. La Migraña con AURA a cualquier edad es una condición de CATEGORÍA 4 de la OMS (Riesgo inaceptable para la salud / contraindicación absoluta) para TODOS los métodos anticonceptivos hormonales combinados (ACOs, parche transdérmico y anillo vaginal). Los estrógenos provocan vasoconstricción y microtrombosis cerebral que, sumados a la fisiopatología vasoespástica del aura migrañosa, elevan drásticamente el riesgo de Infarto Cerebral Isquémico (ACV). En cambio, los métodos de solo progestágeno (implante, DIU-LNG, minipíldora) y el DIU de cobre son completamente seguros. B) Incorrecta. El implante es de solo progestágeno y es seguro en migraña con aura. C) Incorrecta. El DIU de cobre no tiene hormonas y es totalmente seguro. D) Incorrecta. El desogestrel no contiene estrógenos. E) Incorrecta. El DIU-LNG es de solo progestágeno local y seguro.

PREGUNTA 44 **Respuesta: B**

Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia

3.02.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La absorción gástrica y duodenal de los comprimidos tarda entre 1 y 2 horas. B) Correcta. De acuerdo a las directrices de la OMS y a la Norma General Técnica de Regulación de la Fertilidad del MINSAL, si una mujer vomitara dentro de las PRIMERAS 2 HORAS posteriores a la ingestión de la píldora de anticoncepción de emergencia de Levonorgestrel, se asume que el fármaco no fue absorbido en cantidad terapéutica suficiente y la paciente DEBE tomar una nueva dosis completa de 1.5 mg lo antes posible, pudiendo administrarse previamente un antiemético (como metoclopramida o domperidona) para asegurar la retención gástrica. C) Incorrecta. El método aún puede ser administrado y no se sabe si habrá fecundación. D) Incorrecta. Los antibióticos no tienen ningún rol en la anticoncepción. E) Incorrecta. No resolver la falta de absorción deja a la paciente totalmente desprotegida.

PREGUNTA 45 **Respuesta: A**

Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

3.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Criterios de Amsel: flujo gris homogéneo + pH >4.5 + test de aminas + (+) células clave = vaginosis bacteriana. Tratamiento: metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días o clindamicina vaginal.

PREGUNTA 46 **Respuesta: C**

Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

3.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Vaginosis Bacteriana: El diagnóstico probable es vaginosis bacteriana, que se trata con metronidazol oral, siendo una alternativa la clindamicina tópica. No se debe confundir con la enfermedad inflamatoria pélvica que se presenta con dolor, flujo purulento y fiebre. El tratamiento para esta última condición consiste en antibióticos (orales o intravenosos según la gravedad) y la extracción del DIU si no hay respuesta en 48 horas.

PREGUNTA 47 **Respuesta: E**

Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

3.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Vaginosis Bacteriana y DIU: La paciente presenta un cuadro clínico compatible con vaginosis bacteriana, la cual se trata con metronidazol vía oral o clindamicina tópica. A diferencia del proceso inflamatorio pélvico que no responde al tratamiento antibiótico después de 48 horas, en la vaginosis bacteriana no es necesario retirar el DIU.

PREGUNTA 48 **Respuesta: A**

Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

3.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

ITU en embarazo: cefalexina oral 500 mg c/6-8h por 7 días es de primera línea en Chile. Ciprofloxacino: contraindicado (artropatía fetal). Cotrimoxazol: contraindicado en tercer trimestre (kernicterus). Nitrofurantoína: evitar en tercer trimestre. Cefalexina: segura en todos los trimestres.

PREGUNTA 49 **Respuesta: B**

3.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

Es una candidiasis genital. De elección se trata con fluconazol 150 mg v.o. por 1 vez.

PREGUNTA 50 **Respuesta: A**

3.01.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

Sangrado uterino masivo con inestabilidad hemodinámica en postmenopáusica con miomatosis: prioridad = estabilización (fluidos + transfusión si necesario) + histerectomía de urgencia.

PREGUNTA 51 **Respuesta: B**

3.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

A) Incorrecta. El fluconazol es antifúngico para candidiasis. B) Correcta. La paciente cumple con los 4 Criterios de Amsel para Vaginosis Bacteriana (flujo fino homogéneo blanco-grisáceo, pH > 4.5, test de aminas positivo con KOH y presencia de más de un 20% de células clave o 'clue cells' en el frotis). El tratamiento de primera línea respaldado por el MINSAL y la OMS es el Metronidazol oral a dosis de 500 mg cada 12 horas durante 7 días (o gel de metronidazol tópico). Es un hecho clínico comprobado que la vaginosis bacteriana NO requiere tratamiento de la pareja sexual masculina de rutina, a diferencia de la tricomoniasis. C) Incorrecta. La ceftriaxona es para cervicitis gonocócica. D) Incorrecta. La nistatina es para hongos. E) Incorrecta. La doxiciclina es para clamidia.

PREGUNTA 52 **Respuesta: B**

3.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

A) Incorrecta. La vaginosis cursa con pH elevado > 4.5 y test de aminas positivo, sin prurito intenso ni eritema. B) Correcta. La combinación de prurito vulvar severo, antecedente reciente de tratamiento antibiótico, leucorrea espesa grumosa en 'leche cortada' con placas adherentes a una mucosa intensamente eritematosa, asociado a un pH vaginal NORMAL ÁCIDO (< 4.5) y test de aminas negativo es la manifestación clásica e inequívoca de una Candidiasis Vulvovaginal. Se trata con Fluconazol 150 mg oral dosis única o Clotrimazol vaginal. C) Incorrecta. La tricomoniasis cursa con flujo espumoso verdoso, pH alcalino > 5.0 y colpitis en fresa. D) Incorrecta. La cervicitis cursa con secreción endocervical purulenta sin afectación vulvar primaria. E) Incorrecta. La vaginitis atrófica ocurre en la postmenopausia con mucosa pálida y pH alcalino.

PREGUNTA 53 **Respuesta: C**

3.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

A) Incorrecta. Múltiples ensayos clínicos han demostrado que tratar a la pareja masculina en la vaginosis bacteriana no previene las recurrencias. B) Incorrecta. La candidiasis no se clasifica como una ITS; el tratamiento de la pareja asintomática no está indicado. C) Correcta. La Tricomoniasis es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) clásica en la que el varón suele actuar como portador asintomático del protozoo en la uretra y próstata. Por esta razón, el tratamiento simultáneo de la pareja sexual (con Metronidazol 2g oral en dosis única o 500 mg cada 12 horas por 7 días) junto con la indicación de abstinencia coital es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO en todos los casos para prevenir la reinfección inmediata de la mujer y detener la transmisión comunitaria. D) Incorrecta. Es un cuadro no infeccioso idiopático mediado por inmunidad. E) Incorrecta. La cistitis por E. coli no es una ITS y no requiere tratamiento de la pareja.

PREGUNTA 54 **Respuesta: B**

3.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

A) Incorrecta. El metronidazol no cubre Neisseria gonorrhoeae ni Chlamydia trachomatis. B) Correcta. El cuadro de secreción purulenta endocervical con cuello friable corresponde a una Cervicitis Mucopurulenta aguda. Dado que los dos agentes causales más frecuentes y graves son Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis y que la coinfección es muy habitual, la norma ministerial y los CDC recomiendan el tratamiento empírico inmediato combinado de amplio espectro: Ceftriaxona 500 mg intramuscular dosis única (para gonococo) MÁS Doxiciclina 100 mg cada 12 horas vía oral por 7 días (para Chlamydia). Se debe citar a la pareja para tratamiento simultáneo. C) Incorrecta. El gonococo tiene altísima resistencia a aminopenicilinas y no cubre Chlamydia. D) Incorrecta. Es un antifúngico ineficaz contra bacterias. E) Incorrecta. El clotrimazol es un antifúngico tópico.

PREGUNTA 55 **Respuesta: D** **Proceso inflamatorio pelviano** 3.01.1.025 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene un proceso inflamatorio pélvico, no complicado, por lo que se trata con antibióticos de amplio espectro.

PREGUNTA 56 **Respuesta: B**

Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos

3.02.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Las fluoroquinolonas tienen elevadísima resistencia para Neisseria gonorrhoeae en Chile y no se recomiendan como monoterapia. B) Correcta. La paciente presenta una Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP) Estadio I de Monif diagnosticada por los Criterios de Hager (dolor hipogástrico, dolor cervical a la movilización, dolor anexial y fiebre). Al ser de manejo ambulatorio, el esquema oficial ministerial y de los CDC es la triple terapia durante 14 DÍAS: 1) Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única (cobertura de gonococo); 2) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por vía oral por 14 días (cobertura de Chlamydia trachomatis); y 3) Metronidazol 500 mg cada 12 horas por vía oral por 14 días (cobertura indispensable para anaerobios pélvicos). Requiere control clínico en 48-72 horas. C) Incorrecta. No cubre adecuadamente Chlamydia ni alcanza niveles tubáricos óptimos. D) Incorrecta. No cubre gonococo ni clamidia. E) Incorrecta. No cubre clamidia y una dosis única es inútil para EIP.

PREGUNTA 57 **Respuesta: B**

Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos

3.02.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Monif I tolera vía oral y es de manejo ambulatorio. B) Correcta. La presencia de un Absceso Tubo-Ovárico (ATO) (Monif Estadio III) es un criterio absoluto e indiscutido de HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA. El ATO conlleva un alto riesgo de rotura intraperitoneal catastrófica con sepsis grave y peritonitis fecal/purulenta, y requiere antibioticoterapia endovenosa continua de amplio espectro a dosis máximas (ej. Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol o Clindamicina + Gentamicina) y monitorización intrahospitalaria estricta para definir si responde o requiere drenaje quirúrgico. C) Incorrecta. El antecedente previo no obliga a hospitalizar si el episodio actual es leve. D) Incorrecta. Se trata ambulatoriamente. E) Incorrecta. Se debe insistir en el contacto, pero no es criterio médico de ingreso.

PREGUNTA 58 **Respuesta: A**

Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos

3.02.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. El Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis o Perihepatitis asociada a EIP es una complicación clásica provocada por la diseminación ascendente transperitoneal de Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhoeae desde la pelvis a lo largo de las correderas parietocólicas hacia el espacio perihepático. Cursa con dolor agudo en hipocondrio derecho (que simula colecistitis o pleuritis) y formación característica de adherencias peritoneales translúcidas en 'cuerdas de violín' entre la cápsula hepática y el diafragma/pared anterior. El tratamiento consiste en completar el esquema antibiótico para EIP, el cual es altamente curativo. B) Incorrecta. No produce adherencias en cuerdas de violín. C) Incorrecta. Es la trombosis de suprahepáticas con hepatomegalia y ascitis masiva. D) Incorrecta. Lesión ocupante de espacio piógena hepática. E) Incorrecta. Infección supurativa con trombosis portal.

PREGUNTA 59 **Respuesta: B**

Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos

3.02.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La colonoscopía está absolutamente contraindicada ante peritonitis perforada. B) Correcta. El deterioro clínico catastrófico repentino con dolor peritoneal difuso, contractura abdominal en tabla (vientre peritoneal) e inestabilidad hemodinámica severa (shock séptico/hipovolémico) en una paciente hospitalizada por un ATO representa una Rotura de Absceso Tubo-Ovárico (Estadio IV de Monif). Es una emergencia quirúrgica de extrema gravedad con altísima mortalidad materna. La conducta mandatoria es la resucitación hemodinámica con fluidos y traslado inmediato a pabellón para LAPAROTOMÍA EXPLORADORA DE URGENCIA con lavado profuso de la cavidad abdominal, desbridamiento y salpingooforectomía del anexo comprometido. C) Incorrecta. La heparina no trata la peritonitis purulenta. D) Incorrecta. Esperar ante un shock séptico por rotura de ATO conduce a la muerte de la paciente en pocas horas. E) Incorrecta. El cuadro es estrictamente peritoneal pélvico.

PREGUNTA 60 **Respuesta: A**

Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

3.02.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. En una mujer menopáusica sintomática histerectomizada (sin útero) que no tiene contraindicaciones, el tratamiento hormonal de elección indiscutido es la Monoterapia con Estrógenos Solos (ej. 17-beta estradiol oral o transdérmico). Dado que la paciente no tiene útero, no existe riesgo de hiperplasia ni adenocarcinoma de endometrio, por lo que NO se debe prescribir progestágeno; la adición innecesaria de progestágenos aumenta el riesgo de cáncer de mama y eventos adversos sin aportar ningún beneficio clínico adicional. B) Incorrecta. El progestágeno solo se añade para proteger el endometrio en pacientes con útero intacto. C) Incorrecta. Los progestágenos solos son inferiores para sofocos y no aportan protección ósea ni vascular. D) Incorrecta. No es la indicación para síntomas vasomotores del climaterio. E) Incorrecta. La histerectomía previa no es contraindicación; al contrario, simplifica la TRH a estrógenos puros.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A**

Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

3.02.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. El antecedente personal o la sospecha de Cáncer de Mama es una CONTRAINDICACIÓN FORMAL ABSOLUTA para cualquier formulación de Terapia de Reemplazo Hormonal sistémica, debido a que los estrógenos estimulan la proliferación de células mamarias residuales y aumentan drásticamente el riesgo de recidiva o progresión tumoral. En estas pacientes, los bochornos deben manejarse con alternativas no hormonales (como venlafaxina, paroxetina o gabapentina). B) Incorrecta. La osteoporosis es una indicación aprobada de TRH en mujeres dentro de la ventana de oportunidad. C) Incorrecta. La atrofia es una indicación directa de tratamiento. D) Incorrecta. La menopausia precoz es una indicación prioritaria de TRH para proteger corazón y hueso hasta los 50 años. E) Incorrecta. Es la indicación clásica y óptima de TRH.

PREGUNTA 62 **Respuesta: A**

Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

3.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un probable cáncer de cuello uterino. Se debe biopsiar, idealmente en la colposcopía (aunque también se puede biopsiar directamente). El PAP (citología) ya no sirve

---

PREGUNTA 63 **Respuesta: B**

Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

3.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Cáncer cervicouterino.

PREGUNTA 64 **Respuesta: C**

Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

3.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Biopsia cervical

PREGUNTA 65 **Respuesta: B**

Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

3.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Manejo de ASCUS (Células Escamosas Atípicas de Significado Incierto): Vale la pena recordar que las indicaciones más importantes para realizar una colposcopía y biopsia cervical son: Lesión cervical independiente del resultado de la prueba de Papanicolaou (PAP). PAP de tipo glandular, independientemente del grado. PAP escamoso de alto grado. Presencia del virus del papiloma humano (VPH) de alto grado, independientemente del resultado del PAP. PAP escamoso de bajo grado con VPH de bajo grado. Con lo anterior, se puede deducir el manejo de las ASCUS: existes 3 opciones: observar, controlar en 1 año y solicitar una prueba de VPH (la más aceptada). Si VPH(+): Se realiza colposcopía y biopsia, ya que cumple con el criterio de PAP de bajo grado más VPH de bajo grado. Si VPH(-): Se puede optar por la observación o un nuevo PAP en 6 a 12 meses. La opción más recomendada por las guías internacionales es solicitar un nuevo PAP. En menores de 25 años con ASCUS, también se solicita la prueba de VPH, pero se sigue en 1 (si VPH+) o 3 años (si VPH-).

PREGUNTA 66 **Respuesta: C**

3.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

El PAP de alto grado siempre va a colposcopía y biopsia. La tipificación de VPH no ha demostrado ser un buen examen y la guía Minsal solo lo tiene como opción ante el ASCUS (PAP de bajo grado) y no para el ASCH (alto grado).

PREGUNTA 67 **Respuesta: A**

3.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

Las NIE 1 en su mayoría involucionan espontáneamente

PREGUNTA 68 **Respuesta: B**

3.01.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

Es una enfermedad de Paget clásica, que es una Gpo de cáncer de mama, en específico un carcinoma in situ, que se exGende por el pezón y la areola. Es característico el engrosamiento de la piel, con descamación y presencia de costras. Se debe buscar la presencia de otro cáncer de mama (mamografías, etc.). Se diagnostica con biopsia. El tratamiento es resorte del especialista. Fuente imagen: hxps://www.revistamsp.com.

PREGUNTA 69 **Respuesta: B**

3.02.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

A) Incorrecta. Repetir el PAP posterga inaceptablemente el diagnóstico de una lesión premaligna de alto grado que puede albergar cáncer invasor oculto. B) Correcta. En el marco del Programa Nacional de Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino (GES N° 3), todo informe de PAP con Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado (LIEAG / H-SIL) exige la notificación de garantía GES y la derivación inmediata y obligatoria a la Unidad de Patología Cervical (UPC) de nivel secundario para la realización de una Colposcopía con biopsia dirigida y eventual legrado endocervical en un plazo máximo garantizado de 30 días. C) Incorrecta. Los óvulos no tratan las neoplasias intraepiteliales. D) Incorrecta. La histerectomía sin confirmación diagnóstica colposcópica e histológica previa es una mala praxis quirúrgica grave. E) Incorrecta. La vacuna es profiláctica, no tiene ningún efecto terapéutico sobre lesiones preexistentes.

PREGUNTA 70 **Respuesta: C**

3.02.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

A) Incorrecta. La cirugía radical está formalmente CONTRAINDICADA cuando el tumor invade los parametrios (Estadio IIB en adelante), debido a que no permite lograr bordes quirúrgicos libres y aumenta masivamente las fístulas urinarias sin beneficio en sobrevida. B) Incorrecta. La conización es exclusiva de lesiones preinvasoras o microinvasoras IA1. C) Correcta. El límite biológico y quirúrgico consensuado internacionalmente (FIGO, NCCN, MINSAL) para operar el cáncer cervicouterino es la indemnidad de los parametrios. Desde el momento en que existe invasión parametrial demostrada al tacto rectovaginal (Estadio IIB), el tratamiento curativo estándar de elección es la Quimiorradioterapia Concomitante basada en Cisplatino semanal asociado a Radioterapia Externa pélvica y Braquiterapia intracavitaria de alta tasa de dosis. Este esquema alcanza excelentes tasas de control local sin la morbilidad de una cirugía no R0. D) Incorrecta. La histerectomía simple deja tumor parametrial activo. E) Incorrecta. El Estadio IIB es potencialmente curable con quimiorradioterapia definitiva.

PREGUNTA 71 **Respuesta: B**

3.02.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

A) Incorrecta. El tamizaje masivo anual en menores de 25 años sobretrata infecciones transitorias por VPH sin reducir la mortalidad. B) Correcta. La Guía Clínica de Cáncer Cervicouterino del MINSAL y las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 3) definen que la población beneficiaria de tamizaje poblacional universal está constituida por las mujeres de 25 a 64 años de edad, mediante el examen de Papanicolaou (PAP) cada 3 años (tras dos controles anuales iniciales consecutivos negativos). Este intervalo trienal maximiza el costo-efectividad y reduce la incidencia de cáncer invasor en más del 80%. C) Incorrecta. El rango 50 a 69 años bienal corresponde al tamizaje de Cáncer de Mama por mamografía. D) Incorrecta. El uso de ACOs no altera el intervalo trienal de tamizaje. E) Incorrecta. El tamizaje debe ser periódico a lo largo de toda la vida reproductiva y perimenopáusica.

PREGUNTA 72 **Respuesta: B**

Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

3.02.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Los serotipos 6 y 11 son de bajo riesgo oncogénico y son los causantes del 90% de los condilomas acuminados (verrugas anogenitales benignas). B) Correcta. Los serotipos 16 y 18 del Virus Papiloma Humano son los principales agentes carcinogénicos de alto riesgo oncogénico para el epitelio cervical. El serotipo 16 es responsable de aproximadamente el 55-60% de los carcinomas epidermoides de cuello uterino, y el serotipo 18 es responsable del 15% de los carcinomas epidermoides y de más del 50% de los adenocarcinomas endocervicales. Ambos están cubiertos por la vacuna del PNI chileno. C) Incorrecta. Los serotipos 1 y 2 causan verrugas vulgares y plantares cutáneas. D) Incorrecta. Son serotipos de bajo riesgo. E) Incorrecta. Asociados a epidermodisplasia verruciforme en piel.

BLOQUE 5 ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: C** **Tumores ováricos**

3.01.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un cáncer de ovario clásico.

PREGUNTA 74 **Respuesta: B**

Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

3.01.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un fibroadenoma clásico (joven con nódulo liso y móvil).

PREGUNTA 75 **Respuesta: B**

Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

3.02.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El control a los 6 meses es la conducta exclusiva de la categoría BI-RADS 3 (< 2% de riesgo), jamás de una lesión BI-RADS 4. B) Correcta. Todo hallazgo radiológico clasificado como BI-RADS 4 (sospechoso de malignidad con riesgo de 2 a 95%) o BI-RADS 5 (> 95%) tiene indicación formal y mandatoria de confirmación histológica mediante Biopsia Percutánea con Aguja Gruesa (Core Biopsy o Tru-Cut) guiada por ecografía o estereotaxia. Este procedimiento obtiene cilindros de tejido que permiten diagnosticar invasión del estroma y realizar el panel inmunohistoquímico completo (RE, RP, HER2 y Ki-67). C) Incorrecta. Mutilar una mama sin diagnóstico histológico previo es una mala praxis inadmisible. D) Incorrecta. La PAAF solo aporta células aisladas que no permiten distinguir carcinoma in situ de carcinoma invasor ni medir adecuadamente los receptores. E) Incorrecta. La hormonoterapia requiere confirmación histológica de neoplasia con receptores positivos.

PREGUNTA 76 **Respuesta: A**

Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

3.02.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. El estándar oncológico internacional y las guías del MINSAL establecen como regla de oro indiscutible que TODA Cirugía Conservadora de Mama (tumorectomía o cuadrantectomía) DEBE ir seguida obligatoriamente de RADIOTERAPIA EXTERNA ADYUVANTE sobre la glándula mamaria residual. Los ensayos clínicos clásicos (NSABP B-06) demostraron que la cirugía conservadora MÁS radioterapia ofrece exactamente la misma tasa de sobrevida global a largo plazo que la mastectomía radical, pero omitir la radioterapia eleva la tasa de recidiva local a más del 25-35%. B) Incorrecta. El metotrexato intratecal es para leucemias o metástasis meníngeas. C) Incorrecta. El vaciamiento axilar se evita si el ganglio centinela es negativo. D) Incorrecta. No tiene indicación en cáncer de mama. E) Incorrecta. Omitir la radioterapia tras tumorectomía es un error terapéutico grave.

PREGUNTA 77 **Respuesta: B**

Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

3.02.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El fibroadenoma es un nódulo móvil que no se comunica con los conductos principales ni produce telorrea hemática. B) Correcta. La causa benigna más frecuente de telorrea serohemática o hemática unilateral, unicanalicular (que brota por un único poro del pezón) y espontánea en mujeres en edad reproductiva o perimenopáusica es el Papiloma Intraductal Benigno. Consiste en una pequeña proliferación de epitelio ductal vascularizado que asienta en los conductos galactóforos principales retroareolares. Debe estudiarse con ecografía/mamografía y resolverse mediante resección del conducto afectado (microdoquectomía) para descartar un carcinoma papilar subyacente. C) Incorrecta. El prolactinoma produce galactorrea (leche blanquecina) bilateral, pluriorificial y sin sangre. D) Incorrecta. Cursa con masa inflamatoria dolorosa abscedada recurrente. E) Incorrecta. La ectasia ductal produce secreción pluriorificial, bilateral, espesa y verdosa/pardusca.

PREGUNTA 78 **Respuesta: B**

3.02.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

A) Incorrecta. El tamoxifeno requiere que los receptores de estrógeno sean positivos. B) Correcta. El tumor que resulta negativo para los tres marcadores clásicos (RE negativo, RP negativo y HER2 negativo) se clasifica como Cáncer de Mama Triple Negativo. Representa aproximadamente el 15% de los cánceres mamarios y se asocia con mayor frecuencia a pacientes jóvenes y portadoras de mutaciones en el gen BRCA1. Desde el punto de vista terapéutico, al carecer de receptores hormonales y de la proteína HER2, este tumor NO se beneficia de la hormonoterapia (tamoxifeno/anastrozol) ni de la terapia dirigida anti-HER2 (Trastuzumab); su tratamiento médico descansa fundamentalmente en la Quimioterapia Citotóxica combinada. C) Incorrecta. El HER2 es negativo; el trastuzumab es ineficaz. D) Incorrecta. Los inhibidores de aromatasa exigen receptores hormonales positivos. E) Incorrecta. El triple negativo es un carcinoma muy agresivo con alta tasa de recidiva temprana.

PREGUNTA 79 **Respuesta: E**

3.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

Tiene factores de riesgo de cáncer de endometrio (obesidad y nuliparidad) y además células endometriales. Se debe descartar una hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio, partiendo por la Eco.

PREGUNTA 80 **Respuesta: A**

3.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

Caso clínico oficial EUNACOM para Patología maligna del endometrio.

PREGUNTA 81 **Respuesta: D**

3.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

Tiene una metrorragia posmenopáusica, que por tener un endometrio de 5 mm o más, debe biopsiarse con técnica Pipelle. El antecedente de tamoxifeno aumenta mucho el riesgo de cáncer de endometrio e hiperplasia endometrial (premaligna).

PREGUNTA 82 **Respuesta: D**

3.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

Por tener metrorragia postmenopáusica, más un endometrio mayor o igual a 5 mm, se debe biopsiar (con TRH es mayor o igual a 9 mm).

PREGUNTA 83 **Respuesta: E**

3.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

Solicitar biopsia endometrial

PREGUNTA 84 **Respuesta: B**

3.02.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

A) Incorrecta. Los estrógenos locales tratan la atrofia, pero ante un endometrio de 12 mm retrasarían el diagnóstico de un adenocarcinoma. B) Correcta. El sangrado postmenopáusico es el síntoma de presentación del Cáncer de Endometrio en el 90% de los casos. La presencia de un grosor endometrial ecográfico ≥ 4 a 5 mm en una mujer menopáusica exige de forma mandatoria e impostergable la obtención de una muestra histológica mediante Biopsia Endometrial (la aspiración ambulatoria con cánula de Pipelle es el método de primera línea por su alta sensibilidad y bajo costo, recurriéndose a histeroscopía si la muestra no es concluyente). C) Incorrecta. El PET-CT no sustituye la biopsia histológica primaria. D) Incorrecta. La conducta expectante ante sospecha de neoplasia ginecológica es negligencia. E) Incorrecta. La causa del sangrado reside en el endometrio uterino, no en los ovarios.

PREGUNTA 85 **Respuesta: B**

3.02.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

A) Incorrecta. Los quistes foliculares solo ocurren en mujeres fértiles ovuladoras, no en postmenopáusicas de 65 años. B) Correcta. La constelación clínica de síntomas digestivos subagudos (distensión, saciedad precoz) asociada a ascitis, una masa anexial con todos los criterios IOTA de malignidad (multiloculada, tabiques gruesos, papilas sólidas y flujo Doppler central) y un marcador tumoral CA-125 marcadamente elevado en una mujer postmenopáusica es diagnóstica de Cáncer Epitelial de Ovario Avanzado. La conducta es la derivación urgente a un centro terciario oncológico para cirugía citorreductora primaria máxima (debulking) y posterior quimioterapia con carboplatino y paclitaxel. C) Incorrecta. La punción percutánea o transvaginal de una masa ovárica con sospecha de cáncer está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA por el gravísimo riesgo de rotura capsular y siembra masiva de células tumorales en la cavidad peritoneal. D) Incorrecta. Los endometriomas no tienen papilas ni se asocian a ascitis masiva en postmenopáusicas. E) Incorrecta. El cuadro es una neoplasia ovárica primaria con carcinomatosis.

PREGUNTA 86 **Respuesta: B**

3.02.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

A) Incorrecta. No causa hemorragia digestiva. B) Correcta. La punción evacuadora de un tumor ovárico sospechoso de cáncer está estrictamente proscrita en la ginecología oncológica moderna. Si el tumor corresponde a un carcinoma ovárico confinado al ovario (Estadio IA), la punción accidental o deliberada de la cápsula produce el derrame de líquido cargado de células neoplásicas viables hacia el peritoneo libre, transformando inmediatamente la enfermedad en un Estadio IC (peor pronóstico) y multiplicando drásticamente el riesgo de carcinomatosis peritoneal y muerte. Toda masa ovárica sospechosa debe extirparse quirúrgicamente íntegra sin romper su cápsula. C) Incorrecta. La elevación de CA-125 es un marcador tumoral secundario, no el daño biológico. D) Incorrecta. No tiene que ver con permeabilidad tubárica. E) Incorrecta. Salvo el excepcional estruma ovárico, no causa tirotoxicosis.

PREGUNTA 87 **Respuesta: C**

3.02.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

A) Incorrecta. La multiparidad es un factor protector (la progesterona del embarazo descama y protege el endometrio). B) Incorrecta. Los ACOs combinados protegen fuertemente contra el cáncer de endometrio (reducen el riesgo en un 50%). C) Correcta. El adenocarcinoma de endometrio tipo I es un tumor hormonodependiente vinculado a la exposición prolongada a estrógenos sin la oposición protectora de la progesterona ('estrógenos sin oposición'). La Obesidad es el factor de riesgo más importante en países occidentales, debido a que el exceso de tejido adiposo contiene enzima aromatasa que convierte masivamente los andrógenos suprarrenales (androstenediona) en estrona. Asimismo, el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) perpetúa ciclos anovulatorios crónicos sin fase lútea ni secreción de progesterona. D) Incorrecta. Curiosamente, el tabaquismo ejerce un leve efecto antiestrogénico hepático y reduce discretamente el riesgo de cáncer de endometrio (aunque aumenta muchos otros cánceres). E) Incorrecta. El DIU-LNG produce atrofia endometrial y es fuertemente protector.

PREGUNTA 88 **Respuesta: D**

3.01.2.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico

Torsión ovárica: Aunque el cuadro clínico inicial puede asemejarse al de una apendicitis aguda, la presencia de un tumor anexial en la ecografía sugiere una torsión ovárica. El tamaño del tumor es un factor de riesgo importante: los tumores de más de 10 cm presentan el mayor riesgo, mientras que los que miden más de 5 cm tienen un riesgo intermedio. En este caso, incluso si el flujo Doppler color en la ecografía hubiera sido normal, la presencia de un tumor anexial grande en el contexto clínico descrito obliga a realizar una laparoscopía urgente, de modo de destorsionar el ovario inmediatamente y prevenir la necrosis ovárica.

PREGUNTA 89 **Respuesta: B**

Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico

3.02.1.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Enviar a domicilio a una paciente con torsión ovárica causa la necrosis y pérdida irreversible del ovario en pocas horas. B) Correcta. La Torsión Ovárica es una emergencia quirúrgica isquémica por compromiso vascular del ligamento infundíbulo-pélvico. En mujeres jóvenes en edad reproductiva, el estándar quirúrgico internacional exige la intervención inmediata mediante Laparoscopía de urgencia para realizar la DETORSIÓN OVÁRICA CONSERVADORA (desenrollar el anexo sobre su eje) para restaurar el flujo sanguíneo y preservar el parénquima ovárico y la fertilidad. El ovario tiene una extraordinaria capacidad de recuperación funcional aun tras horas de isquemia clínica. C) Incorrecta. La punción no resuelve la torsión del pedículo y agrega riesgo de infección. D) Incorrecta. No es un cuadro infeccioso; el compromiso es isquémico mecánico. E) Incorrecta. La ooforectomía sistemática de entrada sin intentar detorsión es una práctica desaconsejada y mutilante en mujeres jóvenes.

PREGUNTA 90 **Respuesta: B**

Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico

3.02.1.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La cirugía abierta es invasiva y desproporcionada para un cuadro estable. B) Correcta. El cuadro clínico de dolor pélvico agudo postcoital en fase lútea tardía, asociado a los hallazgos ecográficos patognomónicos de un quiste con patrón reticular en 'red de pesca' y líquido libre escaso en una paciente hemodinámicamente estable (PA 118/74, FC 78, hematocrito normal de 40%), corresponde a un Quiste Ovárico Hemorrágico Roto no complicado. La conducta de elección es el MANEJO MÉDICO CONSERVADOR EXPECTANTE con analgesia, reposo y observación clínica. El sangrado del lecho quístico se autolimitada espontáneamente y el hemoperitoneo leve se reabsorbe sin necesidad de cirugía. C) Incorrecta. La laparoscopía solo está indicada si existe inestabilidad hemodinámica, hemoperitoneo masivo o caída persistente del hematocrito. D) Incorrecta. El metotrexato es para el embarazo ectópico (la prueba de gestación fue negativa). E) Incorrecta. La paciente tiene un hematocrito normal y no requiere transfusión.
